



## 医患沟通 题库 (240题)

科目：医患沟通（第3版·2024） | 目标考试：期末考试 | 批次：batch019

题型：A1(58) A2(78) A3(20) A4(3) B1(24) X型(40) 判断(17)

Bloom：记忆33.3% | 理解37.9% | 应用23.8% | 分析5.0%

### 第一章 绪论

#### 1. YHGT-Ch1-A1-001

A1型题 | 记忆 | 正选题 | 难度0.75 | P1-P5

沟通的特征不包括下列哪一项？

- A. 双向性
- B. 互动性
- C. 单向传递性 ☒
- D. 情境性
- E. 符号性

正确答案：C

💡 沟通的特征包括双向性、互动性、情境性和符号性。单向传递性不是沟通的特征，沟通本质是双向互动的过程。

⚠️ 易错点：可能将信息传递与沟通混淆，认为沟通就是单向告知。

#### 2. YHGT-Ch1-A1-002

A1型题 | 记忆 | 正选题 | 难度0.7 | P10

功能沟通的具体内容包括三个层面，其中"解决为什么的问题"属于哪个层面？

- A. 事实部分
- B. 论证部分 ☒
- C. 发展趋势部分
- D. 情感支持部分
- E. 决策部分

正确答案：B

💡 功能沟通三方面：事实部分解决"是什么"、论证部分解决"为什么"、发展趋势部分解答"此后将怎样发展"。

⚠️ 易错点：容易混淆"论证"与"事实"。"是什么"对应事实部分，"为什么"对应论证部分。

### 3. YHGT-Ch1-A1-003

A1型题 | 理解 | 正选题 | 难度0.65 | 📖 P10

关于情感沟通在医患沟通中的意义，下列描述最准确的是？

- A. 替代功能沟通，成为主要的沟通形式
- B. 仅用于精神病患者的诊疗过程
- C. 是可有可无的辅助性沟通
- D. 增强理解与信任，提高患者依从性和满意度 ✓
- E. 主要用于处理医疗纠纷时

正确答案：D

💡 情感沟通的意义在于增强理解与信任，进而提高依从性和满意度。情感沟通贯穿诊疗全程，不可替代功能沟通。

⚠️ 易错点：可能低估情感沟通的重要性，认为它只是辅助手段。

### 4. YHGT-Ch1-A1-004

A1型题 | 理解 | ● 反选题 | 难度0.55 | 📖 P3-P8

医患沟通的作用不包括下列哪一项？

- A. 促进正确诊断与治疗 ✓
- B. 提供情感支持与心理安慰 ✓
- C. 帮助患者知情决策 ✓
- D. 构建和谐医患关系 ✓
- E. 替代客观辅助检查

正确答案：E

💡 医患沟通四大作用：促进诊断治疗、提供情感支持、帮助知情决策、构建和谐关系。沟通不能替代客观辅助检查，两者互补。本题为反选题——E的polarity为false。

⚠️ 易错点：可能高估沟通作用，认为沟通可替代某些检查。

## 5. YHGT-Ch1-A1-005

A1型题 | 记忆 | 正选题 | 难度0.8 | 📖 P11-P13

医患沟通中"善用语言交流技巧"的核心要求不包括？

- A. 多用专业术语以体现权威性 ☒
- B. 积极倾听患者的叙述
- C. 表达共情与理解
- D. 清晰解释病情与治疗方案
- E. 给予明确的指导建议

正确答案：A

💡 语言交流技巧核心是倾听、共情、解释和指导。多用专业术语会阻碍患者理解，与正确做法相反。

⚠️ 易错点：部分学生认为专业术语可增加权威，实际效果相反。

## 6. YHGT-Ch1-A1-006

A1型题 | 理解 | 正选题 | 难度0.6 | 📖 P14

社会制度因素对医患沟通产生影响，其最主要的机制是？

- A. 直接规定医患双方的对话内容
- B. 通过制度设计影响双方行为预期和互动模式 ☒
- C. 替代医患之间的直接沟通
- D. 仅影响医疗费用的支付方式
- E. 完全消除医患信息不对称

正确答案：B

💡 社会制度（医保、分级诊疗等）通过塑造行为预期和互动模式间接影响沟通，不直接规定对话内容，也不能消除信息不对称。

⚠️ 易错点：可能忽略制度的间接影响机制，认为制度直接决定沟通内容。

## 7. YHGT-Ch1-A1-007

A1型题 | 理解 | 正选题 | 难度0.7 | 📖 P1-P5

"沟通的效果取决于沟通双方对符号意义的共同理解"，这句话强调了沟通的哪个特征？

- A. 符号性——沟通依赖符号系统且需要共享意义 ☒
- B. 双向性——沟通双方角色可互换
- C. 互动性——沟通双方相互影响
- D. 情境性——沟通受环境影响
- E. 单向性——信息从发送者到接收者

**正确答案：A**

💡 符号性强调沟通依赖语言、文字、表情等符号系统，且沟通双方需要对这些符号有共同的理解。没有共享意义就没有有效沟通。

⚠️ 易错点：可能将符号性与互动性或情境性混淆。

## 8. YHGT-Ch1-A1-008

**A1型题** | 理解 | 正选题 | 难度0.64 | 📖 P10-P13

**医患沟通中"以患者为中心"的沟通模式与传统"以疾病为中心"模式的最大区别在于？**

- A. 以患者为中心不需要关注疾病本身
- B. 以疾病为中心完全不考虑患者感受
- C. 以患者为中心在关注疾病的同时关注患者的体验、价值观和偏好 ☒
- D. 两者完全相同没有区别
- E. 以患者为中心只适用于门诊

**正确答案：C**

💡 以患者为中心不等于不关注疾病，而是在诊疗疾病的同时关注患者的整体体验。这是功能沟通和情感沟通的统一。

⚠️ 易错点：可能将"以患者为中心"误解为"不关注疾病"。

## 9. YHGT-Ch1-A2-001

**A2型题(案例分析)** | 应用 | 正选题 | 难度0.6 | 📖 P10-P13

**一位45岁男性患者，初诊高血压病。医生在告知诊断后，详细解释了高血压的病因、可能的并发症以及不治疗的后果，并询问患者是否理解。这体现了功能沟通中的哪类沟通？**

- A. 仅属于事实部分沟通
- B. 仅属于情感支持沟通
- C. 涵盖事实、论证和发展趋势三个层面 ☒
- D. 仅属于论证部分沟通
- E. 属于非功能沟通范畴

正确答案：C

💡 医生解释了病因（事实部分）、并发症后果（论证部分）、病情发展方向（发展趋势部分），涵盖功能沟通全部三个层面。

⚠️ 易错点：可能只看到其中一个层面，忽略医生实际完成了全部三方面的信息传达。

## 10. YHGT-Ch1-A2-002

A2型题(案例分析) | 应用 | 正选题 | 难度0.55 | 📖 P10-P11

一位肿瘤科医生在告知患者确诊肺癌后，发现患者低头沉默、眼眶发红。此时医生最恰当的做法是？

- A. 暂停信息告知，给予情感回应和共情支持 ☒
- B. 加快告知速度，尽快完成病情传达
- C. 立即离开诊室，给患者独处空间
- D. 继续按原计划告知全部治疗方案细节
- E. 告诉患者不要难过，这病一定能治好

正确答案：A

💡 当患者出现明显情绪反应时，应优先进行情感沟通，暂停信息传达，给予共情和支持。忽视情绪继续告知会导致患者无法接收信息。

⚠️ 易错点：可能认为应继续完成告知任务或给虚假安慰。

## 11. YHGT-Ch1-A2-003

A2型题(案例分析) | 应用 | 正选题 | 难度0.58 | 📖 P11-P13

门诊医生接诊一位老年患者，患者描述症状时啰嗦且偏离主题。医生最合适的语言沟通方式是？

- A. 直接打断患者，要求其说重点
- B. 忽略患者叙述，直接按模板问诊
- C. 让护士先与患者沟通以筛选信息
- D. 耐心倾听后用开放提问引导回主题 ☒
- E. 转给其他医生接诊

正确答案：D

💡 善用语言交流技巧包括耐心倾听后引导。先倾听建立信任，再用开放提问引回正轨，既尊重患者又提高效率。

⚠ 易错点：可能认为老年患者沟通耗时，应直接打断以提高效率。

## 12. YHGT-Ch1-A2-004

A2型题(案例分析) | 应用 | 正选题 | 难度0.5 | 📖 P14

某地区实施分级诊疗制度后，基层医生反映患者对转诊决定常有不信任感。从社会制度因素角度分析，最根本的沟通对策是？

- A. 直接告知患者这是政策规定，必须执行
- B. 向患者解释转诊的医学必要性，将制度语言转化为患者利益 ☒
- C. 告知患者直接去大医院就诊，绕过转诊程序
- D. 减少与患者沟通以避免冲突
- E. 仅关注急重症患者的转诊沟通

正确答案：B

💡 社会制度因素影响沟通时，关键在于将制度要求转化为患者的切身利益，而非简单强制执行。

⚠ 易错点：可能将制度执行与患者沟通割裂，认为制度不需向患者解释。

## 13. YHGT-Ch1-A2-005

A2型题(案例分析) | 理解 | 正选题 | 难度0.62 | 📖 P3-P8

从医患沟通作用的角度分析，术前谈话最主要的目的是？

- A. 完成法律告知义务以避免医疗纠纷
- B. 展示医生的专业知识水平
- C. 说服患者接受医生推荐的手术方案
- D. 缩短门诊时间以提高工作效率
- E. 帮助患者知情决策并构建信任关系 ☒

正确答案：E

💡 术前谈话体现了知情决策和构建和谐关系两大作用。虽然也有法律告知功能，但核心目的是让患者理解后自主决策。

⚠ 易错点：可能过度强调法律免责目的，忽略沟通本身的医学和人文价值。

## 14. YHGT-Ch1-A2-006

医生告诉糖尿病患者：其糖化血红蛋白是8.5%，正常应低于6.5%。如果不控制好血糖，可能会出现眼底、肾脏和神经的并发症。这属于功能沟通的哪类？

- A. 仅事实部分，告知检查结果
- B. 仅论证部分，解释不控制的后果
- C. 事实部分和论证部分的结合 ☒
- D. 仅发展趋势部分
- E. 完全属于情感沟通而非功能沟通

正确答案：C

💡 数值告知是事实，并发症警告是论证，两者结合体现了事实和论证两个层面。

⚠️ 易错点：可能仅关注数值告知或仅关注并发症警告，忽略两者结合。

## 15. YHGT-Ch1-A2-007

医患沟通中，医生既传递“您的肿瘤是早期”的客观信息，又表达“我们一起面对”的情感支持。这体现了？

- A. 功能沟通可以部分替代情感沟通
- B. 功能沟通与情感沟通的互补统一 ☒
- C. 仅需功能沟通，情感沟通可有可无
- D. 情感沟通比功能沟通更重要
- E. 两者互相排斥不能同时进行

正确答案：B

💡 客观信息传递（功能沟通）与情感支持（情感沟通）可以也应该在同一场景中互补共存。两者不是替代或排斥关系。

⚠️ 易错点：可能认为一次沟通只能完成一个目的。

## 16. YHGT-Ch1-B1-001a

（共用选项：A.事实部分 B.论证部分 C.发展趋势部分 D.情感支持 E.决策共享）医生告知患者“您的病理报告显示为良性肿瘤”属于？

- A. 事实部分 ☒
- B. 论证部分
- C. 发展趋势部分
- D. 情感支持
- E. 决策共享

**正确答案：A**

💡 "病理报告显示良性肿瘤"是客观事实传达，属于功能沟通中事实部分，解决"是什么"的问题。

⚠️ 易错点：可能将其误归为情感支持，实际这是客观信息传达。

---

## 17. YHGT-Ch1-B1-001b

**B1型题(匹配)** | 理解 | 正选题 | 难度0.65 | 📖 P10

(共用选项同上) 医生告知"术后前3天需要卧床，1周后可下床活动，2周后拆线"属于？

- A. 事实部分
- B. 论证部分
- C. 发展趋势部分 ☒
- D. 情感支持
- E. 决策共享

**正确答案：C**

💡 术后恢复时间节点是告知"此后健康将怎样发展"，属于发展趋势部分。

⚠️ 易错点：可能误归为事实部分，但涉及未来趋势预测属于发展趋势部分。

---

## 18. YHGT-Ch1-B1-001c

**B1型题(匹配)** | 理解 | 正选题 | 难度0.68 | 📖 P10

(共用选项同上) 医生解释"因为您的血压长期控制不佳，所以导致了左心室肥厚"属于？

- A. 事实部分
- B. 论证部分 ☒
- C. 发展趋势部分
- D. 情感支持
- E. 决策共享

**正确答案：B**



💡 "因为...所以..."的因果关系解释属于功能沟通中论证部分，解决"为什么"的问题。

⚠️ 易错点：可能被"左心室肥厚"误导为事实部分，核心是因果解释。

## 19. YHGT-Ch1-B1-002a

B1型题(匹配) | 记忆 | 正选题 | 难度0.78 | 📖 P1-P5

(共用选项：A.双向性 B.互动性 C.情境性 D.符号性 E.单向性) 沟通双方互为发送者和接收者，体现的是沟通的？

- A. 双向性 ☒
- B. 互动性
- C. 情境性
- D. 符号性
- E. 单向性

正确答案：A

💡 沟通双方互为发送者和接收者，这是双向性的定义。互动性指相互影响和反馈。

⚠️ 易错点：双向性和互动性容易混淆。双向性强调角色可互换，互动性强调相互影响。

## 20. YHGT-Ch1-B1-002b

B1型题(匹配) | 记忆 | 正选题 | 难度0.75 | 📖 P1-P5

(共用选项同上) 同样的病情告知，在诊室和病房走廊产生的效果不同，这体现了沟通的？

- A. 双向性
- B. 互动性
- C. 情境性 ☒
- D. 符号性
- E. 单向性

正确答案：C

💡 沟通效果受物理环境、社会背景等情境因素影响，同一信息在不同环境中效果不同，体现了情境性。

⚠️ 易错点：可能将环境因素误判为沟通的互动性影响。

## 21. YHGT-Ch1-B1-003a

B1型题(匹配) | 理解 | 正选题 | 难度0.7 | P3-P8

(共用选项: A.促进诊断治疗 B.情感支持 C.知情决策 D.和谐关系 E.经济评估) 通过详细问诊和倾听, 医生发现了患者未主动提及的关键症状, 这体现了医患沟通的哪项作用?

- A. 促进诊断治疗 ☒
- B. 情感支持
- C. 知情决策
- D. 和谐关系
- E. 经济评估

正确答案: A

💡 通过有效沟通发现隐藏的关键症状, 直接促进了诊断的准确性和完整性, 体现的是沟通对诊疗的技术性贡献。

⚠️ 易错点: 可能将发现隐藏症状归因于情感支持或和谐关系。

## 22. YHGT-Ch1-B1-003b

B1型题(匹配) | 理解 | 正选题 | 难度0.68 | P3-P8

(共用选项同上) 患者说"虽然我的病很难治, 但医生每次耐心解释让我心里踏实多了", 这体现的是医患沟通的哪项作用?

- A. 促进诊断治疗
- B. 情感支持
- C. 知情决策
- D. 和谐关系 ☒
- E. 经济评估

正确答案: D

💡 "心里踏实多了"是信任和关系改善的体现, 属于构建和谐医患关系的作用。虽然也涉及情感支持, 但核心是关系层面的改善。

⚠️ 易错点: 可能将关系改善归因于情感支持或知情决策。

## 23. YHGT-Ch1-J-001

判断题 | 理解 | 正选题 | 难度0.7 | P10

功能沟通可以完全替代情感沟通在医患关系中的作用。

- A. 正确  
B. 错误 ☒

**正确答案：B**

💡 功能沟通和情感沟通是互补而非替代关系。功能沟通传达医学事实，情感沟通建立信任，两者缺一不可。

⚠️ 易错点：可能高估功能沟通的作用，忽略情感沟通的独立价值。

## 24. YHGT-Ch1-J-002

判断题 | 理解 | 正选题 | 难度0.75 | 📖 P1-P5

**医患沟通本质上是一个双向互动的过程，而非单向的信息告知。**

- A. 正确 ☒  
B. 错误

**正确答案：A**

💡 沟通的特征包括双向性和互动性。医患沟通作为沟通的特殊形式，本质上是双向互动的过程。

⚠️ 易错点：可能将医患沟通理解为医生对患者的单向信息传达。

## 25. YHGT-Ch1-X-001

X型题(多选) | 记忆 | 正选题 | 难度0.6 | 📖 P3-P8

**医患沟通的作用包括以下哪些方面？（多选）**

- A. 促进正确诊断与治疗 ☒  
B. 提供情感支持与心理安慰 ☒  
C. 替代客观辅助检查  
D. 帮助患者知情决策 ☒  
E. 构建和谐医患关系 ☒

**正确答案：ABDE**

💡 医患沟通四大作用：促进诊断治疗(A)、提供情感支持(B)、帮助知情决策(D)、构建和谐关系(E)。沟通不能替代辅助检查(C错误)。

⚠️ 易错点：可能误选C，高估沟通作用。

## 26. YHGT-Ch1-X-002

X型题(多选) | 记忆 | 正选题 | 难度0.65 | 📖 P10

功能沟通的具体内容包括哪些层面？（多选）

- A. 事实部分，解决是什么的问题 ☒
- B. 论证部分，解决为什么的问题 ☒
- C. 发展趋势部分，解答此后将怎样发展的的问题 ☒
- D. 情感宣泄，释放患者心理压力
- E. 经济评估，核算医疗费用

正确答案：ABC

💡 功能沟通三方面是事实(A)、论证(B)、发展趋势(C)。D属于情感沟通范畴，E不属于沟通内容分类。

⚠️ 易错点：可能将情感宣泄误归为功能沟通。

## 27. YHGT-Ch1-X-003

X型题(多选) | 记忆 | 正选题 | 难度0.68 | 📖 P1-P5

沟通的基本特征包括哪些？（多选）

- A. 双向性 ☒
- B. 互动性 ☒
- C. 单向传递性
- D. 情境性 ☒
- E. 符号性 ☒

正确答案：ABDE

💡 沟通四大特征：双向性、互动性、情境性、符号性。单向传递性不是沟通的特征。

⚠️ 易错点：可能将信息传递的单向性与沟通的双向性混淆。

## 28. YHGT-Ch1-X-004

X型题(多选) | 理解 | 正选题 | 难度0.62 | 📖 P11-P13

以下哪些属于医患沟通中"善用语言交流技巧"的正确做法？（多选）

- A. 多使用专业术语以体现权威性
- B. 积极倾听患者的叙述 ☒

- C. 使用通俗易懂的语言解释病情 ☒
- D. 表达共情与理解 ☒
- E. 给予明确的指导和建议 ☒

**正确答案：BCDE**

💡 善用语言技巧包括倾听(B)、通俗解释(C)、共情(D)、明确指导(E)。多用专业术语(A)会阻碍理解。

⚠️ 易错点：可能误选A，认为专业术语增加权威性。

## 29. YHGT-Ch1-X-005

**X型题(多选)** | 理解 | 正选题 | 难度0.6 | 📖 P10-P13

**关于功能沟通与情感沟通的关系，以下说法正确的是？（多选）**

- A. 功能沟通传达医学事实和知识 ☒
- B. 情感沟通建立信任和理解 ☒
- C. 功能沟通可以部分替代情感沟通
- D. 两者在临床实践中互补共存 ☒
- E. 良好的医患沟通需要功能沟通和情感沟通的统一 ☒

**正确答案：ABDE**

💡 功能沟通和情感沟通各有独立价值，互补共存。C错误地认为可以替代。

⚠️ 易错点：可能认为只需关注功能沟通或只需情感沟通。

## 第二章 医患沟通的理论基础

### 30. YHGT-Ch2-A1-001

**A1型题** | 记忆 | 正选题 | 难度0.75 | 📖 P16-P18

**伦理学的性质和任务是什么？**

- A. 研究疾病的自然规律
- B. 制定医疗技术操作规范
- C. 调整和处理人际关系的行为规范 ☒
- D. 研究药物作用机制
- E. 评估医疗经济效益

**正确答案：C**

💡 伦理学是研究道德规范的学科，其性质和任务是调整和处理人际关系的行为规范。在医患沟通中，伦理道德提供了行为准则。

⚠️ 易错点：可能将伦理学与医学技术学科混淆。

## 31. YHGT-Ch2-A1-002

A1型题 | 记忆 | 正选题 | 难度0.7 | 📖 P16-P19

医学与伦理的关系中，医学的"善"指的是？

- A. 医学知识的科学性
- B. 医疗技术的先进性
- C. 医疗行为的艺术性
- D. 医学的仁爱精神和利他主义 ☒
- E. 医疗机构的规模等级

正确答案：D

💡 医学的"真"指科学性、"善"指仁爱精神、"美"指艺术性。善体现了医学的仁爱 and 利他本质。

⚠️ 易错点：容易将真、善、美三者混淆。"真"对科学、"善"对仁爱、"美"对艺术。

## 32. YHGT-Ch2-A1-003

A1型题 | 理解 | 🚫 反选题 | 难度0.62 | 📖 P19-P21

医患沟通的伦理特征不包括以下哪一项？

- A. 信息不对称性 ☒
- B. 双方知识水平完全对等
- C. 信任依赖性 ☒
- D. 隐私涉入性 ☒
- E. 关系不对等性 ☒

正确答案：B

💡 医患沟通的伦理特征包括信息不对称、信任依赖、隐私涉入和关系不对等。双方知识水平完全对等是错误的。本题为反选题。

⚠️ 易错点：可能认为理想状态是双方知识对等，但现实中信息不对称是客观存在的伦理特征。

### 33. YHGT-Ch2-A1-004

A1型题 | 记忆 | 正选题 | 难度0.68 | 📖 P21-P23

以下哪项属于患方的权利？

- A. 如实告知病史和症状
- B. 遵守医院的规章制度
- C. 配合医师的诊疗方案
- D. 按规定支付医疗费用
- E. 对病情和治疗方案享有知情权 ☒

正确答案：E

💡 患方权利包括知情权、选择权、隐私权和同意权。A/B/C/D均为患方义务，而非权利。

⚠️ 易错点：容易将权利与义务混淆。权利是"可以要求什么"，义务是"应当做什么"。

---

### 34. YHGT-Ch2-A1-005

A1型题 | 记忆 | 正选题 | 难度0.78 | 📖 P16

生物-心理-社会医学模式的提出者是？

- A. 希波克拉底
- B. Engel（恩格尔） ☒
- C. 弗洛伊德精神分析
- D. 奥斯勒医学人文
- E. 南丁格尔

正确答案：B

💡 1977年，美国罗切斯特大学Engel教授在Science杂志提出生物-心理-社会医学模式。

⚠️ 易错点：可能将Engel与其他医学历史人物混淆。

---

### 35. YHGT-Ch2-A1-006

A1型题 | 记忆 | 正选题 | 难度0.72 | 📖 P25-P27

关于焦虑的定义，下列描述最准确的是？

- A. 对未知的、潜在的威胁产生的担忧和不安情绪 ☒
- B. 对已知危险产生的即时恐惧反应
- C. 一种重性精神疾病的诊断标准

- D. 仅发生于ICU患者的特殊心理状态
- E. 等同于抑郁症的核心症状

**正确答案：A**

💡 焦虑是对未知的、潜在威胁产生的担忧和不安。恐惧是对已知危险的反应。

⚠️ 易错点：可能将焦虑与恐惧混淆，或将焦虑等同于精神疾病。

---

## 36. YHGT-Ch2-A1-007

**A1型题** | 理解 | 正选题 | 难度0.58 | 📖 P27-P29

**以下哪项属于医者的常见心理特征？**

- A. 对疾病预后的盲目乐观
- B. 对患者痛苦的完全麻木
- C. 职业倦怠与共情疲劳风险 ☒
- D. 对医疗风险的完全回避
- E. 不需要任何心理支持

**正确答案：C**

💡 医者常见心理特征包括职业倦怠、共情疲劳、成就感需求与挫败感并存等。医生心理健康同样需要关注。

⚠️ 易错点：可能将医生理想化为"无所不能"，忽视其心理压力。

---

## 37. YHGT-Ch2-A1-008

**A1型题** | 记忆 | 正选题 | 难度0.66 | 📖 P29-P31

**人际知觉中的"首因效应"是指？**

- A. 最近获得的信息对判断影响最大
- B. 对某一群体的固定看法影响个体判断
- C. 某个突出特征影响整体评价
- D. 初次见面的第一印象对后续判断的影响 ☒
- E. 在沟通过程中完全消除个人偏见

**正确答案：D**

💡 首因效应即第一印象效应。近因效应指最近信息影响最大，晕轮效应指以偏概全，刻板印象指对群体的固化看法。



⚠ 易错点：容易混淆四种人际知觉效应：首因（首次）、近因（最近）、晕轮（以偏概全）、刻板（群体固化）。

## 38. YHGT-Ch2-A2-001

A2型题(案例分析) | 应用 | 正选题 | 难度0.55 | 📖 P16-P19

一位医生在诊治过程中，既依据循证医学证据选择治疗方案，又耐心倾听患者的顾虑并予以安慰，还注意用通俗比喻解释复杂病理。这体现了医学的？

- A. 仅体现了医学的"真"
- B. 体现了医学真、善、美的统一 ☒
- C. 仅体现了医学的"善"
- D. 仅体现了医学的"美"
- E. 与医学的真善美无关

**正确答案：B**

💡 循证医学证据体现"真"（科学性），倾听安慰体现"善"（仁爱），通俗比喻体现"美"（沟通艺术），三者统一。

⚠ 易错点：可能只看到其中一个维度，忽略医生行为的综合价值。

## 39. YHGT-Ch2-A2-002

A2型题(案例分析) | 应用 | 正选题 | 难度0.52 | 📖 P21-P23

一位患者要求查看自己的全部病历资料，医生以"这是医院内部文件"为由拒绝。该医生违反了患方的哪项权利？

- A. 选择权
- B. 隐私权
- C. 同意权
- D. 知情权 ☒
- E. 免于支付费用的权利

**正确答案：D**

💡 病案资料属于患者知情权涵盖的范围。患者有权了解自己的病情、诊断、治疗方案及病历信息。

⚠ 易错点：可能将知情权与隐私权混淆。知情权是主动获取信息的权利，隐私权是保护信息不被泄露的权利。

## 40. YHGT-Ch2-A2-003

A2型题(案例分析) | 应用 | 正选题 | 难度0.58 | 📖 P23-P25

患者隐瞒了正在服用抗凝药物的重要病史，导致医生开具了禁忌药物。从患方义务角度分析？

- A. 患者违反了如实告知义务 ☒
- B. 医生应承担全部责任
- C. 患方没有告知义务
- D. 这属于医院的制度缺陷
- E. 药物禁忌是医生的责任与患者无关

正确答案：A

💡 患方义务包括如实告知病史、症状和用药情况。隐瞒重要病史违反该义务，可能造成严重后果。

⚠️ 易错点：可能将所有医疗责任归于医生，忽略患者自身的告知义务。

## 41. YHGT-Ch2-A2-004

A2型题(案例分析) | 应用 | 正选题 | 难度0.6 | 📖 P25-P27

一位等待手术的患者反复询问“手术会不会出意外”、“麻醉后还能不能醒来”，检查心率偏快、手心出汗。该患者当前最突出的心理状态是？

- A. 抑郁情绪
- B. 愤怒情绪
- C. 焦虑情绪 ☒
- D. 强迫观念
- E. 正常术前反应，无需关注

正确答案：C

💡 患者反复询问不确定性风险、心率快、出汗，是典型的焦虑表现——对未知的、潜在威胁产生的担忧和不安。

⚠️ 易错点：可能将术前焦虑视为“正常反应”而忽略其需要干预的价值。

## 42. YHGT-Ch2-A2-005

A2型题(案例分析) | 应用 | 正选题 | 难度0.56 | 📖 P29-P31

一位年轻女医生首次独立出门诊，患者看到她后说"这么年轻，能看好病吗？"患者这句话反映的人际知觉效应是？

- A. 首因效应
- B. 刻板印象 ☒
- C. 近因效应
- D. 晕轮效应
- E. 投射效应

**正确答案：B**

💡 患者基于"年轻=经验不足"的固化看法对医生做出判断，这属于刻板印象——对某一群体的固定看法影响对个体的判断。

⚠️ 易错点：可能将刻板印象与首因效应混淆。刻板印象基于群体标签，首因效应基于首次接触信息。

## 43. YHGT-Ch2-A2-006

A2型题(案例分析) | 应用 | 正选题 | 难度0.54 | 📖 P31-P34

一位资深医生在面对患者时表现权威，而在科室主任面前表现谦逊。这种现象可用哪个社会学概念解释？

- A. 角色冲突
- B. 角色模糊
- C. 社会角色及其情境转换 ☒
- D. 角色超载
- E. 角色退出

**正确答案：C**

💡 社会角色概念强调个体在不同社会情境中有不同的行为期待。医生面对患者和面对主任时的行为差异，是社会角色情境转换的体现。

⚠️ 易错点：可能将情境性的角色转换与长期的角色冲突混淆。

## 44. YHGT-Ch2-A2-007

A2型题(案例分析) | 理解 | 正选题 | 难度0.58 | 📖 P16-P19

医生在告知患者病情时，既准确传达了"冠心病三支病变"的客观诊断（真），又耐心安抚患者情绪并帮助其建立治疗信心（善），还用心脏模型直观解释病变位置（美）。这一沟通行为体现了？

- A. 医学只需追求科学真理
- B. 良好的医患沟通仅靠仁爱之心即可
- C. 善和美比真更重要
- D. 医学真善美在沟通实践中的有机统一 ☒
- E. 真善美三者互相独立不可兼得

**正确答案：D**

💡 该场景完美体现了医学真（科学诊断）、善（人文关怀）、美（沟通艺术）三者的统一。三者不是割裂的而是互补的。

⚠️ 易错点：可能偏重其中一个维度而忽略统一性。

## 45. YHGT-Ch2-A2-008

**A2型题(案例分析)** | 理解 | 正选题 | 难度0.62 | 📖 P25-P27

患者入院后表现出反复询问病情、睡眠差、食欲下降，但各项检查均在正常范围。从患者心理特征角度，该患者最主要的问题可能是？

- A. 器质性疾病未被发现
- B. 疾病不确定感引发的焦虑情绪 ☒
- C. 对医院环境的不适应
- D. 单纯的失眠障碍
- E. 对医生的不信任

**正确答案：B**

💡 检查正常但反复询问、睡眠食欲变化是典型的疾病不确定感导致的焦虑——患者对未知的健康威胁产生担忧。

⚠️ 易错点：可能首先考虑器质性疾病而忽略心理因素。

## 46. YHGT-Ch2-A2-009

**A2型题(案例分析)** | 理解 | 正选题 | 难度0.56 | 📖 P29-P31

一位医生发现自己在接诊衣冠整洁、谈吐得体的患者时更有耐心，而对衣着朴素的患者容易草率。该医生可能受到了哪种人际知觉效应的影响？

- A. 首因效应
- B. 近因效应
- C. 晕轮效应 ☒

- D. 刻板印象
- E. 移情效应

**正确答案：C**

💡 以衣着外貌这一突出特征影响对患者整体的态度，是典型的晕轮效应——以偏概全。

⚠️ 易错点：可能将晕轮效应与刻板印象混淆。刻板印象基于群体标签，晕轮基于个体突出特征。

## 47. YHGT-Ch2-A2-010

**A2型题(案例分析)** | 理解 | 正选题 | 难度0.62 | 📖 P21-P25

**患者有权复印自己的病历资料，这主要体现的是患方的哪项权利？**

- A. 患者的同意权
- B. 患者的选择权
- C. 知情权——了解自身医疗信息的权利 ☒
- D. 患者的隐私权
- E. 参与研究权

**正确答案：C**

💡 复印病历是知情权的延伸——患者有权获取和查看自己的医疗信息。隐私权是保护信息不被他人获取，方向相反。

⚠️ 易错点：可能将知情权与隐私权混淆。知情是获取信息，隐私是保护信息。

## 48. YHGT-Ch2-A2-011

**A2型题(案例分析)** | 理解 | 正选题 | 难度0.54 | 📖 P31-P34

**社会角色理论中，"角色冲突"是指？**

- A. 个体在不同情境中扮演同一角色
- B. 个体完全无法扮演任何社会角色
- C. 个体同时承担的两个或多个角色之间存在矛盾期待 ☒
- D. 个体对角色的理解与实际情况完全一致
- E. 社会对某一角色没有任何行为期待

**正确答案：C**

💡 角色冲突指同时承担的角色之间存在矛盾期待。如医生既要在急诊快速决策（角色1:急救者），又要详细告知家属（角色2:沟通者）。

⚠ 易错点：可能将角色冲突与角色模糊或角色扮演混淆。

## 49. YHGT-Ch2-A2-012

A2型题(案例分析) | 理解 | 正选题 | 难度0.6 | 📖 P21-P25

患者要求出院并拒绝继续治疗。主管医生反复解释风险后，患者仍坚持。此时医生尊重患者的决定，这体现了患方的哪项权利？

- A. 患者的知情权
- B. 患者的隐私权
- C. 参与研究权
- D. 获得赔偿权
- E. 选择权——包括拒绝治疗的权利 ☒

正确答案：E

💡 选择权不仅包括选择治疗方案，也包括在知情后拒绝治疗的权利（除非涉及法定传染病等公共安全例外）。医生已履行告知义务，患者自主决定体现了选择权。

⚠ 易错点：可能将选择权局限于“选A还是选B”，忽略拒绝治疗也是选择权。

## 50. YHGT-Ch2-A2-013

A2型题(案例分析) | 应用 | 正选题 | 难度0.56 | 📖 P25-P29

一位住院医师连续值了3个夜班后，发现自己对患者的反复询问变得很不耐烦，下班后感到极度疲惫和空虚。这最可能反映的是？

- A. 正常的疲劳，休息一下就好了
- B. 需要转行不再当医生
- C. 人格缺陷导致的职业不适应
- D. 职业倦怠的早期表现——情绪耗竭和去人格化 ☒
- E. 单纯的睡眠不足

正确答案：D

💡 对患者不耐烦（去人格化）+极度疲惫空虚（情绪耗竭）是职业倦怠的两大核心维度。这是医者常见的心理特征而非个人缺陷，需要系统性干预。

⚠ 易错点：可能将职业倦怠正常化为“多休息就好”或过度归因于个人问题。

## 51. YHGT-Ch2-A2-014

A2型题(案例分析) | 应用 | 正选题 | 难度0.6 |  P21-P25

患者入院时护士要求患者换上病号服并告知探视时间。从患方义务角度，这体现的是？

- A. 遵守医院规章制度的义务 ☒
- B. 如实告知病史的义务
- C. 配合诊疗方案的义务
- D. 支付医疗费用的义务
- E. 保护个人隐私的权利

正确答案：A

 换病号服和遵守探视时间是遵守医院规章制度的义务。这不同于告知病史(B)、配合诊疗(C)和支付费用(D)。

 易错点：可能将遵守规章与其他义务混淆。

## 52. YHGT-Ch2-B1-001a

B1型题(匹配) | 理解 | 正选题 | 难度0.74 |  P16-P19

(共用选项：A.医学之真 B.医学之善 C.医学之美 D.医学之效 E.医学之名) 循证医学强调最佳证据指导临床决策，体现的是？

- A. 医学之真 ☒
- B. 医学之善
- C. 医学之美
- D. 医学之效
- E. 医学之名

正确答案：A

 循证医学基于科学证据，追求客观真理，体现医学之"真"——科学性。

 易错点：可能将科学性误归为"善"，但"真"对科学、"善"对仁爱。

## 53. YHGT-Ch2-B1-001b

B1型题(匹配) | 理解 | 正选题 | 难度0.72 |  P16-P19

(共用选项同上) 医生在患者经济困难时帮助申请医疗救助，体现的是？

- A. 医学之真
- B. 医学之善 ☒
- C. 医学之美
- D. 医学之效
- E. 医学之名

**正确答案：B**

💡 关心患者疾苦、帮助解决困难，体现医学之"善"——仁爱精神和利他主义。

⚠️ 易错点：可能将仁爱行为与技术行为混淆。"善"核心是仁爱关怀。

---

## 54. YHGT-Ch2-B1-002a

**B1型题(匹配)** | 记忆 | 正选题 | 难度0.76 | 📖 P29-P31

（共用选项：A.首因效应 B.近因效应 C.晕轮效应 D.刻板印象 E.投射效应）面试时前30秒的表现往往决定了考官的整体评价，这属于？

- A. 首因效应 ☒
- B. 近因效应
- C. 晕轮效应
- D. 刻板印象
- E. 投射效应

**正确答案：A**

💡 首因效应即第一印象效应——初次接触的信息对整体印象有决定性影响。

⚠️ 易错点：容易混淆首因效应（首次）和近因效应（最近）。

---

## 55. YHGT-Ch2-B1-002b

**B1型题(匹配)** | 理解 | 正选题 | 难度0.7 | 📖 P29-P31

（共用选项同上）因为一位医生外貌英俊，患者便认为其医术也一定高明，这属于？

- A. 首因效应
- B. 近因效应
- C. 晕轮效应 ☒
- D. 刻板印象
- E. 投射效应

**正确答案：C**



💡 晕轮效应是指某个突出特征（如外貌）影响了对其他方面（如医术）的整体评价，即以偏概全。

⚠️ 易错点：可能将晕轮效应与首因效应混淆。晕轮效应是对某个特征的过度泛化。

## 56. YHGT-Ch2-B1-003a

B1型题(匹配) | 记忆 | 正选题 | 难度0.72 | 📖 P21-P25

（共用选项：A.知情权 B.选择权 C.隐私权 D.同意权 E.赔偿权）患者有权了解自己的病情、治疗方案和风险，属于？

- A. 知情权 ☒
- B. 选择权
- C. 隐私权
- D. 同意权
- E. 赔偿权

正确答案：A

💡 知情权指患者了解病情、方案、风险等信息的基本权利。

⚠️ 易错点：容易将知情权与同意权混淆。知情是了解信息，同意是做出决定。

## 57. YHGT-Ch2-B1-003b

B1型题(匹配) | 理解 | 正选题 | 难度0.68 | 📖 P21-P25

（共用选项同上）签署手术知情同意书体现的是患方的？

- A. 知情权
- B. 选择权
- C. 隐私权
- D. 同意权 ☒
- E. 赔偿权

正确答案：D

💡 签署知情同意书是在知情基础上行使同意（或拒绝）的权利，核心体现的是同意权。

⚠️ 易错点：可能将签署行为归为知情权或选择权。

## 58. YHGT-Ch2-J-001

判断题 | 理解 | 正选题 | 难度0.72 | P16

1977年Engel提出的生物-心理-社会医学模式是对传统生物医学模式的补充和超越。

- A. 正确 ☒
- B. 错误

正确答案：A

💡 Engel于1977年提出生物-心理-社会医学模式，强调医学应综合考虑生物、心理和社会因素，是对单纯生物医学模式的超越。

⚠️ 易错点：可能不清楚该模式的提出者和提出时间。

## 59. YHGT-Ch2-J-002

判断题 | 理解 | 正选题 | 难度0.68 | P21-P25

患方的权利和义务是相互对应的，享有权利的同时必须履行相应的义务。

- A. 正确 ☒
- B. 错误

正确答案：A

💡 权利和义务是统一的。患者在接受医疗服务时既享有知情权、选择权等权利，也应履行如实告知、配合诊疗等义务。

⚠️ 易错点：可能片面强调权利而忽略义务。

## 60. YHGT-Ch2-X-001

X型题(多选) | 记忆 | 正选题 | 难度0.63 | P16-P19

医学与伦理的关系中，医学的"真、善、美"分别指什么？（多选）

- A. 医学真——科学性，追求客观真理 ☒
- B. 医学善——仁爱精神，利他主义 ☒
- C. 医学美——艺术性，沟通技巧与人文关怀 ☒
- D. 医学真——医院规模和设备先进性
- E. 医学善——医疗经济收益最大化

正确答案：ABC

💡 医学真指科学性（求真），善指仁爱精神（求善），美指沟通艺术（求美）。D/E是对真善美的曲解。

⚠️ 易错点：可能将设备先进等同于“真”，将经济效益等同于“善”。

## 61. YHGT-Ch2-X-002

X型题(多选) | 记忆 | 正选题 | 难度0.6 | 📖 P21-P23

以下哪些属于患方的权利？（多选）

- A. 对病情的知情权 ☒
- B. 对治疗方案的选择权 ☒
- C. 个人隐私保护权 ☒
- D. 遵守医院规章制度的义务
- E. 签署知情同意书的同意权 ☒

正确答案：ABCE

💡 患方权利包括知情权(A)、选择权(B)、隐私权(C)、同意权(E)。D属于患方义务而非权利。

⚠️ 易错点：可能将权利与义务混淆。

## 62. YHGT-Ch2-X-003

X型题(多选) | 记忆 | 正选题 | 难度0.62 | 📖 P23-P25

以下哪些属于患方的义务？（多选）

- A. 如实告知病史和症状 ☒
- B. 自行选择任何想要的治疗方案
- C. 配合医师的诊疗方案 ☒
- D. 遵守医院的规章制度 ☒
- E. 按规定支付医疗费用 ☒

正确答案：ACDE

💡 患方义务包括如实告知(A)、配合诊疗(C)、遵守规章(D)、支付费用(E)。B是选择权而非义务。

⚠️ 易错点：可能将权利误认为义务。选择治疗方案是权利不是义务。

## 63. YHGT-Ch2-X-004

X型题(多选) | 记忆 | 正选题 | 难度0.58 | 📖 P19-P21

医患沟通的伦理特征包括哪些？（多选）

- A. 信息不对称性 ☒
- B. 双方知识水平完全对等
- C. 信任依赖性 ☒
- D. 隐私涉入性 ☒
- E. 关系不对等性 ☒

正确答案：ACDE

💡 医患沟通伦理特征包括信息不对称、信任依赖、隐私涉入、关系不对等。B与事实相反，医患之间存在专业知识差距。

⚠️ 易错点：可能认为理想的医患关系应该知识对等，但现实中信息不对称是客观特征。

## 64. YHGT-Ch2-X-005

X型题(多选) | 记忆 | 正选题 | 难度0.55 | 📖 P29-P31

人际知觉中的常见效应包括哪些？（多选）

- A. 首因效应——第一印象的影响 ☒
- B. 近因效应——最新信息的影响 ☒
- C. 晕轮效应——以偏概全 ☒
- D. 刻板印象——对群体的固化看法 ☒
- E. 共振效应——医患情绪同步

正确答案：ABCD

💡 人际知觉四大效应为首因(A)、近因(B)、晕轮(C)、刻板(D)。E不是人际知觉的标准效应。

⚠️ 易错点：可能自创效应名称。"共振效应"在人际知觉中没有此分类。

## 65. YHGT-Ch2-X-006

X型题(多选) | 理解 | 正选题 | 难度0.56 | 📖 P16-P19

医学真善美在临床沟通中的体现，以下正确的是？（多选）

- A. 真——基于循证医学证据制定方案 ☒
- B. 真——对患者说善意的谎言
- C. 善——对患者痛苦表达理解和关怀 ☒
- D. 善——满足患者所有要求
- E. 美——用通俗生动的语言解释复杂医学问题 ☒

**正确答案：ACE**

💡 真=科学(A非B)，善=仁爱(C非D)，美=艺术(E)。善意的谎言(B)本质是不诚实，无原则满足(D)可能有害。

⚠️ 易错点：可能将"善意的谎言"误认为善，或将全盘满足误认为关怀。

## 66. YHGT-Ch2-X-007

**X型题(多选)** | 理解 | 正选题 | 难度0.58 | 📖 P25-P29

**以下哪些属于医者的心理特征和心理需求？（多选）**

- A. 职业倦怠风险 ☒
- B. 对患者的痛苦完全无感
- C. 从成功救治中获得成就感的需求 ☒
- D. 长期共情工作导致的共情疲劳 ☒
- E. 在高压力的工作环境中需要心理支持 ☒

**正确答案：ACDE**

💡 医者常见心理特征包括职业倦怠(A)、成就感需求(C)、共情疲劳(D)、心理支持需求(E)。B是对医者心理的错误描述。

⚠️ 易错点：可能将医者理想化为"永远积极"而忽略其真实心理需求。

## 第三章 医患沟通基本技能

### 67. YHGT-Ch3-A1-001

**A1型题** | 记忆 | 正选题 | 难度0.72 | 📖 P39-P42

**中国医师协会提出的人文医学执业技能培训体系主要针对什么？**

- A. 外科手术技能培训
- B. 护理操作技能培训
- C. 医患沟通基本能力培训 ☒

- D. 医院管理能力培训
- E. 临床科研方法培训

**正确答案：C**

💡 中国医师协会人文医学执业技能培训体系旨在提升医生的医患沟通基本能力，包括共情、语言沟通、非语言沟通等核心人文技能。

⚠️ 易错点：可能将人文医学技能与临床操作技能混淆。

## 68. YHGT-Ch3-A1-002

**A1型题** | 理解 | 正选题 | 难度0.6 | 📖 P39-P41

**关于共情(empathy)与同情(sympathy)的区别，下列描述正确的是？**

- A. 两者完全相同，可以互换使用
- B. 同情比共情更有利于医患沟通
- C. 共情是一种自然情感，不需要专门训练
- D. 同情是平等的理解，共情是居高临下的怜悯
- E. 共情是我懂你的平等理解，同情是我可怜你的不平等情感 ☒

**正确答案：E**

💡 共情(empathy)是感同身受的平等理解；同情(sympathy)是居高临下的怜悯。共情是医生核心技能需专门训练。

⚠️ 易错点：容易将共情与同情混为一谈。共情是专业能力需训练，同情是自然情感。

## 69. YHGT-Ch3-A1-003

**A1型题** | 记忆 | 正选题 | 难度0.74 | 📖 P42-P46

**非语言沟通不包括以下哪项？**

- A. 面部表情与眼神接触
- B. 身体姿态与手势
- C. 沟通距离与空间位置
- D. 病历中的书面诊断结论 ☒
- E. 语音语调与语速的变化

**正确答案：D**

💡 非语言沟通包括体态语言、空间距离、触摸和副语言。书面诊断结论属于语言沟通的书面形式。

⚠ 易错点：可能将书面文字也归为非语言沟通。非语言沟通指不依赖语言文字的方式。

---

## 70. YHGT-Ch3-A1-004

A1型题 | 记忆 | 正选题 | 难度0.7 | 📖 P47-P50

医患沟通的通用步骤采用什么模式？

- A. 早期-中期-后期三段式模式 ☒
- B. 单向告知模式
- C. 问答-诊断-处方三步骤
- D. 随机应变模式，无固定步骤
- E. 仅适用于住院患者的沟通模式

正确答案：A

💡 医患沟通通用步骤采用早期（建立关系）-中期（解决问题）-后期（总结计划）三段式模式。

⚠ 易错点：可能将三段式与传统诊疗流程混淆。

---

## 71. YHGT-Ch3-A1-005

A1型题 | 理解 | 正选题 | 难度0.56 | 📖 P47-P48

在病史采集的沟通中，沟通早期最应该做什么？

- A. 直接询问患者的具体症状细节
- B. 善于观察倾听，发现核心问题线索 ☒
- C. 先向患者解释可能的诊断
- D. 直接开具检查申请单
- E. 告知患者需要遵守的注意事项

正确答案：B

💡 沟通早期应敏锐发现核心问题。医生不要急于按自己的思路询问（易先入为主），要善于观察和倾听。

⚠ 易错点：可能急于获取具体信息而跳过观察和倾听阶段。

---

## 72. YHGT-Ch3-A1-006

A1型题 | 理解 | 正选题 | 难度0.63 | 📖 P47

## 沟通早期处理患者情绪的重要性在于？

- A. 情绪不影响沟通效果，可以忽略
- B. 情绪化的患者应推迟到下次再沟通
- C. 不良情绪会导致患者曲解信息，增加沟通难度 ☒
- D. 医生应当先安抚患者直到其完全冷静
- E. 情绪问题仅属于精神科范畴

**正确答案：C**

💡 情绪状态和思维、行为间有较强交互作用。带着情绪的患者容易曲解医生话语，增加沟通困难。

⚠️ 易错点：可能认为情绪问题与医学沟通无关。

## 73. YHGT-Ch3-A2-001

A2型题(案例分析) | 应用 | 正选题 | 难度0.57 | 📖 P39-P41

一位乳腺癌患者术后对医生说："我知道你们都尽力了，但我就是觉得很难受。"医生回答道："我明白你现在的感受，失去乳房对任何女性都是巨大的打击。"医生的回应体现了什么技能？

- A. 同情 (sympathy)
- B. 共情 (empathy) ☒
- C. 说服 (persuasion)
- D. 安慰 (comforting)
- E. 解释 (explanation)

**正确答案：B**

💡 医生理解并表达了对患者感受的共鸣 ("我明白你的感受")，这是共情的典型表现——我懂你的平等理解，而非居高临下的怜悯。

⚠️ 易错点：可能将共情与同情混淆。共情是"我懂你"，同情是"我可怜你"。

## 74. YHGT-Ch3-A2-002

A2型题(案例分析) | 应用 | 正选题 | 难度0.54 | 📖 P42-P46

医生在与一位听力障碍的老年患者沟通时，身体微微前倾、保持眼神接触、适当放慢语速并辅以手势。这些做法主要运用了？



- A. 语言沟通技巧
- B. 书面沟通技巧
- C. 药物辅助沟通
- D. 非语言沟通技巧 ☒
- E. 第三方翻译沟通

**正确答案：D**

💡 身体前倾、眼神接触、手势均属于非语言沟通（体态语言和副语言）。在特殊人群沟通中，非语言沟通尤为重要。

⚠️ 易错点：可能忽略非语言沟通在特殊人群沟通中的重要性。

## 75. YHGT-Ch3-A2-003

**A2型题(案例分析)** | 应用 | 正选题 | 难度0.52 | 📖 P47-P50

一位新入院患者在医生问诊结束后说："医生，我还有个问题，我这个病会不会影响我以后的工作？"此时处于沟通的哪个阶段？医生应如何处理？

- A. 早期阶段，应重新开始建立关系
- B. 中期阶段，应详细展开新话题
- C. 后期阶段，应在总结计划中回应患者关切 ☒
- D. 不属于任何阶段，可忽略该问题
- E. 应转给心理咨询师处理

**正确答案：C**

💡 患者提问发生在问诊结束后，属于沟通后期（总结计划阶段）。此时应回应患者关切并纳入后续计划。

⚠️ 易错点：可能认为额外问题不属于标准流程而忽略。

## 76. YHGT-Ch3-A2-004

**A2型题(案例分析)** | 应用 | 正选题 | 难度0.5 | 📖 P50-P53

医生需要告知患者确诊恶性肿瘤的消息。按照SPIKES模型，第一步应该做什么？

- A. 直接告知诊断结果
- B. 询问患者家属是否在场
- C. 安排私密环境，确保充足的沟通时间 ☒
- D. 向患者说明治疗方案
- E. 评估患者的支付能力

**正确答案：C**

💡 SPIKES模型第一步S(Setting up)是安排私密环境、邀请家属陪同、确保充足时间坐下沟通，为后续步骤做好环境准备。

⚠️ 易错点：可能急于告知诊断而忽略环境安排。

## 77. YHGT-Ch3-A2-005

**A2型题(案例分析)** | 理解 | 正选题 | 难度0.6 | 📖 P47-P48

病史采集时患者主诉"头晕"，医生追问"是感觉天旋地转还是头重脚轻"。这种提问方式在沟通中属于？

- A. 封闭式提问——限制了患者的表达
- B. 聚焦澄清——帮助患者精确描述症状 ☒
- C. 诱导式提问——引导患者说出期望答案
- D. 开放式提问——鼓励患者自由表达
- E. 重复式提问——确认患者之前说过的内容

**正确答案：B**

💡 从模糊的"头晕"到区分"旋转性/非旋转性"，是沟通中期聚焦和澄清的技巧，帮助精确化关键症状信息。

⚠️ 易错点：可能将聚焦澄清误认为封闭式提问或诱导式提问。

## 78. YHGT-Ch3-A2-006

**A2型题(案例分析)** | 理解 | 正选题 | 难度0.54 | 📖 P50-P53

医生使用SPIKES模型告知坏消息时，在"Invitation"步骤中应该？

- A. 直接告知患者全部病情细节
- B. 请家属回避以便单独沟通
- C. 评估患者的经济承受能力
- D. 立即给出治疗方案
- E. 询问患者希望了解多少信息 ☒

**正确答案：E**

💡 Invitation步骤的核心是获取患者"想知道多少"的许可——有些患者希望了解全部细节，有些只想知道大概。

⚠️ 易错点：可能跳过这一步直接进入告知，忽略患者的知情意愿差异。

---

## 79. YHGT-Ch3-A2-007

A2型题(案例分析) | 理解 | 正选题 | 难度0.62 | 📖 P47-P48

一位医生在问诊时习惯性地边写病历边提问，很少抬头看患者。从非语言沟通角度，这最主要的问题是？

- A. 缺乏眼神接触和身体朝向，传递了“不关注”的非语言信息 ☒
- B. 书写病历比沟通更重要
- C. 患者更喜欢医生专注于记录
- D. 这是在节省时间的高效做法
- E. 非语言沟通在问诊中不重要

**正确答案：A**

💡 缺乏眼神接触和身体朝向是典型的非语言沟通失误——传递了“我对你不感兴趣”的信息，即使医生的语言是恰当的。

⚠️ 易错点：可能认为问诊就是获取信息，忽略非语言沟通的重要性。

---

## 80. YHGT-Ch3-A2-008

A2型题(案例分析) | 理解 | 正选题 | 难度0.62 | 📖 P39-P41

年轻女医生在面对流产患者时说“没关系，你还年轻，以后还能再生”。从共情角度看，这句话的问题在于？

- A. 信息完全准确且表达恰当
- B. 这是同情而非共情——以“以后还能再生”轻描淡写地否定了当下的痛苦 ☒
- C. 表达了对患者生育能力的关心
- D. 充分体现了以患者为中心的沟通
- E. 正确运用了情感沟通技巧

**正确答案：B**

💡 “没关系”“以后还能再生”是典型的同情式回应——从外部视角“怜悯”和“轻描淡写”，而非从患者内部视角理解“当下的失去”。共情应该先承认痛苦而非急着安慰。

⚠️ 易错点：可能以为“积极安慰”就是共情。

---

## 81. YHGT-Ch3-A2-009

A2型题(案例分析) | 理解 | 正选题 | 难度0.58 | 📖 P42-P46

一位医生在告知患者检查结果全是正常后，患者反而表现出失望。医生注意到患者双臂交叉、身体后仰。从非语言沟通角度，医生接下来应该？

- A. 忽略患者的非语言信号，继续下一个患者
- B. 直接询问"你为什么失望"
- C. 告知患者正常结果应该高兴
- D. 认为患者在故意找麻烦
- E. 识别非语言信号并用开放式提问邀请患者表达担忧 

**正确答案：E**

 非语言信号（双臂交叉/后仰/失望表情）提示患者有未表达的需求或担忧。医生应识别并用开放式提问引导患者表达。

 易错点：可能忽略非语言信号或直接对峙。

## 82. YHGT-Ch3-A2-010

A2型题(案例分析) | 理解 | 正选题 | 难度0.6 |  P47-P50

在病史采集的中期阶段，医生需要将开放式提问获取的信息进行聚焦和验证。以下哪项最符合"澄清"技巧？

- A. "您刚才说胸口不舒服，能具体描述是闷痛、刺痛还是烧灼感吗？" 
- B. "您的问题我已经了解了，下面开检查单"
- C. "您的情况比较复杂，建议转上级医院"
- D. "不用描述那么详细，回答我的问题就行"
- E. "您说的这些都不重要，关键是检查结果"

**正确答案：A**

 澄清是帮助患者将模糊描述转化为精确信息的关键技巧——将"胸口不舒服"具体化为闷痛/刺痛/烧灼感等可操作的临床描述。

 易错点：可能认为直接按模板提问更高效。

## 83. YHGT-Ch3-A2-011

A2型题(案例分析) | 应用 | 正选题 | 难度0.54 |  P50-P53

医生告知一位年轻女性患者CT发现肺部结节，需要进一步检查。患者瞬间面色苍白、双手发抖。按照SPIKES模型，此时处于哪个步骤？应做什么？

- A. K+E——给予信息后立即共情回应情绪反应 
- B. S——重新布置沟通环境
- C. I——再次询问患者想知道多少
- D. P——重新评估患者已知多少
- E. 跳过所有步骤直接讨论治疗方案

**正确答案：A**

💡 医生产生了情绪反应说明已进入K(Knowledge)步骤（信息已给出），此时应立即转入E(Empathy)步骤——共情回应情绪。SPIKES不是线性执行而是可循环的。

⚠️ 易错点：可能认为情绪反应意味着需要回到前序步骤。

---

## 84. YHGT-Ch3-J-001

判断题 | 理解 | 正选题 | 难度0.74 | 📖 P39-P41

共情(empathy)和同情(sympathy)是同一概念的不同表述，在临床实践中可以互换使用。

- A. 正确
- B. 错误 

**正确答案：B**

💡 共情和同情有本质区别。共情是平等的理解（我懂你），同情是居高临下的怜悯（我可怜你）。共情是需训练的专业技能。

⚠️ 易错点：容易将两个概念混淆。

---

## 85. YHGT-Ch3-J-002

判断题 | 理解 | 正选题 | 难度0.7 | 📖 P47-P50

医患沟通通用步骤采用早期-中期-后期三段式模式，每个阶段都有相应的阶段任务。

- A. 正确 
- B. 错误

**正确答案：A**

💡 医患沟通通用步骤确实采用三段式模式：早期建立关系、中期解决问题、后期总结计划。

⚠️ 易错点：可能认为沟通没有固定模式。

---

## 86. YHGT-Ch3-X-001

X型题(多选) | 记忆 | 正选题 | 难度0.58 | 📖 P39-P42

中国医师协会人文医学执业技能培训体系提出的医患沟通基本能力包括哪些？（多选）

- A. 共情能力 ☒
- B. 非语言沟通能力 ☒
- C. 语言沟通能力 ☒
- D. 病史采集沟通能力 ☒
- E. 告知坏消息的沟通能力 ☒

正确答案：ABCDE

💡 该培训体系涵盖五大基本能力：共情、非语言沟通、语言沟通、病史采集沟通和告知坏消息沟通。

⚠️ 易错点：可能不熟悉该培训体系的具体内容。

## 87. YHGT-Ch3-X-002

X型题(多选) | 记忆 | 正选题 | 难度0.65 | 📖 P42-P46

非语言沟通包括哪些形式？（多选）

- A. 面部表情和眼神接触 ☒
- B. 身体姿态和手势 ☒
- C. 沟通距离和空间位置 ☒
- D. 语音语调和语速 ☒
- E. 书面病历记录

正确答案：ABCD

💡 非语言沟通包括体态语言(A/B)、空间距离(C)、副语言(D)。E属于书面语言沟通。

⚠️ 易错点：可能将书面记录误归为非语言沟通。

## 第四章 医患沟通能力的培养与评估

### 88. YHGT-Ch4-A1-001

A1型题 | 记忆 | 正选题 | 难度0.72 | 📖 P55-P60

医患沟通学习目标通常包含哪三个维度？

- A. 诊断、治疗、康复
- B. 问诊、查体、处方
- C. 门诊、住院、随访
- D. 知识、技能、态度 ☒
- E. 倾听、解释、指导

**正确答案：D**

💡 医患沟通学习目标采用KSA三维模型：知识(Knowledge)、技能(Skill)、态度(Attitude)。这对应Bloom认知、技能和情感领域。

⚠️ 易错点：可能将学习目标与临床流程混淆。

## 89. YHGT-Ch4-A1-002

**A1型题** | 理解 | 正选题 | 难度0.62 | 📖 P60-P65

关于量表测评法在医患沟通能力评估中的应用，以下哪项是其不足？

- A. 测评结果完全客观无偏倚
- B. 适用于所有文化背景无需调整
- C. 存在主观偏倚且受情境和文化差异影响 ☒
- D. 测评成本极低无需培训
- E. 可用于辅助实际沟通场景的观察评估

**正确答案：C**

💡 量表测评法存在三大不足：主观偏倚、情境依赖性、文化差异性。量表单靠自评难以全面反映真实沟通能力。

⚠️ 易错点：可能高估量表的客观性和普适性。

## 90. YHGT-Ch4-A2-001

**A2型题(案例分析)** | 应用 | 正选题 | 难度0.56 | 📖 P55-P60

某医学院在医患沟通课程中，不仅要求学生背诵沟通原则，还通过标准化病人(SP)模拟训练和临床实习中的360度评价来考核。这体现了沟通学习目标的哪个维度？

- A. 仅知识维度
- B. 知识、技能和态度三个维度的整合 ☒
- C. 仅技能维度
- D. 仅态度维度
- E. 不属于任何维度，是额外的考核要求

**正确答案：B**

💡 背诵原则对应知识维度，SP模拟对应技能维度，360度评价涵盖态度维度。三者整合体现完整的KSA评价体系。

⚠️ 易错点：可能认为沟通课程只需考核知识掌握。

## 91. YHGT-Ch4-A2-002

**A2型题(案例分析)** | 应用 | 正选题 | 难度0.54 | 📖 P60-P65

某医院使用SEGUE量表评估住院医师的医患沟通能力。评估发现某医师在“理解患者观点”维度得分偏低。以下哪项最能帮助该医师改进？

- A. 增加医学知识的学习
- B. 更多观摩手术操作
- C. 通过标准化病人训练，专项练习共情和换位思考 ☒
- D. 转岗到不需要沟通的科室
- E. 量表评分不重要可以忽略

**正确答案：C**

💡 沟通能力评估的价值在于发现具体薄弱维度并进行针对性训练。“理解患者观点”维度反映的是共情和换位思考能力，需要通过专项训练（如SP模拟）来提升。

⚠️ 易错点：可能认为沟通能力是天生的无法训练，或认为评估没有实际意义。

## 92. YHGT-Ch4-J-001

**判断题** | 理解 | 正选题 | 难度0.68 | 📖 P60-P65

量表测评法虽能提供量化数据，但存在主观偏倚、情境依赖和文化差异等局限性，不宜作为医患沟通能力的唯一评估方式。

- A. 正确 ☒
- B. 错误

**正确答案：A**

💡 该陈述准确指出了量表测评法的三大局限性，并建议应结合多种评估方式。

⚠️ 易错点：可能认为量化就是客观的，忽略量表本身的局限性。



### 93. YHGT-Ch4-X-001

X型题(多选) | 记忆 | 正选题 | 难度0.64 | P55-P60

医患沟通的学习目标KSA模型包括哪些维度？（多选）

- A. 知识（Knowledge）——掌握沟通理论和方法 ✓
- B. 技能（Skill）——运用沟通技巧于临床 ✓
- C. 态度（Attitude）——培养以患者为中心的态度 ✓
- D. 行政（Administration）——学习医院管理流程
- E. 研究（Research）——开展沟通相关临床研究

正确答案：ABC

💡 KSA模型三维度：知识(A)、技能(B)、态度(C)。D/E不是沟通学习目标的核心维度。

⚠️ 易错点：可能将管理或研究能力也归入沟通学习目标。

### 94. YHGT-Ch4-X-002

X型题(多选) | 记忆 | 正选题 | 难度0.58 | P60-P65

量表测评法在医患沟通评估中存在哪些不足？（多选）

- A. 主观偏倚——自评可能高估或低估实际能力 ✓
- B. 情境依赖性——不同临床场景下表现不一 ✓
- C. 客观性极强——可以完全避免评估者主观影响
- D. 文化差异性——不同文化对沟通行为的评价标准不同 ✓
- E. 成本低廉——是所有评估方法中最经济的

正确答案：ABD

💡 量表测评法不足包括主观偏倚(A)、情境依赖(B)、文化差异(D)。C与不足相反，E虽可能是优势但非不足。

⚠️ 易错点：可能只关注量表的便利性而忽略其方法论局限。

## 第五章 医方主体的沟通

### 95. YHGT-Ch5-A1-001

A1型题 | 记忆 | 正选题 | 难度0.74 | P71-P73

医学协会与医方主体的关系主要体现在？

- A. 医学协会直接参与临床诊疗决策
- B. 医学协会替代医院管理层进行人事管理
- C. 行业自律、规范制定和权益维护 ☒
- D. 医学协会是政府卫生行政部门的派出机构
- E. 医学协会直接处理医患纠纷的调解

**正确答案：C**

💡 医学协会的主要功能是行业自律、制定行业规范和执业标准、维护医务人员的合法权益。

⚠️ 易错点：可能将协会职能与行政管理职能混淆。

---

## 96. YHGT-Ch5-A1-002

**A1型题** | 记忆 | 正选题 | 难度0.76 | 📖 P71-P72

**狭义的医方主体是指？**

- A. 包括所有医疗相关机构和协会
- B. 临床一线的医务人员 ☒
- C. 医院行政管理层
- D. 医学教育培训机构
- E. 医疗保险支付机构

**正确答案：B**

💡 狭义的医方主体指直接从事临床医疗服务的医务人员（医生、护士等）。广义的医方主体还包括医疗机构、协会、团队等。

⚠️ 易错点：可能将狭义与广义的医方主体范围混淆。

---

## 97. YHGT-Ch5-A1-003

**A1型题** | 记忆 | 正选题 | 难度0.68 | 📖 P74-P80

**以下哪种医疗团队类型的人数通常为5-12人？**

- A. 多学科团队(MDT)
- B. 虚拟医疗团队
- C. 自我管理型团队
- D. 问题解决型团队 ☒
- E. 医院管理委员会

正确答案：D

💡 问题解决型团队通常由5-12人组成，来自同一科室或部门，针对特定质量问题或改进项目展开工作。

⚠️ 易错点：可能混淆不同团队类型的规模特征。

## 98. YHGT-Ch5-A1-004

A1型题 | 理解 | 正选题 | 难度0.55 | 📖 P78-P80

虚拟医疗团队面临的主要问题不包括？

- A. 沟通延迟和信息传递不畅
- B. 团队成员面对面交流过于频繁 ☒
- C. 跨地域带来的文化差异和信任缺失
- D. 技术平台障碍和数字鸿沟
- E. 团队凝聚力不易建立和维护

正确答案：B

💡 虚拟医疗团队的主要问题包括沟通延迟、信任缺失、文化差异、技术障碍等。面对面交流过于频繁恰恰是虚拟团队的缺失而非问题。

⚠️ 易错点：可能将虚拟团队的优势（灵活）误认为问题。

## 99. YHGT-Ch5-A1-005

A1型题 | 理解 | 正选题 | 难度0.58 | 📖 P77

问题解决型团队的局限性包括？

- A. 决策速度较慢，责任可能分散 ☒
- B. 成员完全独立工作无需协作
- C. 没有明确的团队目标
- D. 组织结构呈严格等级制
- E. 只适用于外科手术团队

正确答案：A

💡 问题解决型团队的局限性主要有决策慢、责任分散、协调成本高。团队虽有目标但运转效率可能受限于集体决策过程。

⚠️ 易错点：可能认为团队合作总是比个人决策更高效。

---

## 100. YHGT-Ch5-A1-006

A1型题 | 理解 | 正选题 | 难度0.56 | 📖 P77

问题解决型团队"责任分散"局限性的核心含义是？

- A. 团队不需要对结果负责
- B. 每个成员承担的责任比个人工作时更大
- C. 团队领导承担全部责任
- D. 集体决策时个人责任感降低，可能出现"搭便车"现象 ☒
- E. 团队成员之间互相推卸全部责任

正确答案：D

💡 责任分散(diffusion of responsibility)是群体决策的常见问题——个体在集体中感觉自己的责任被稀释，投入度和问责感下降。

⚠️ 易错点：可能将责任分散误解为不需要负责或互相推诿。

---

## 101. YHGT-Ch5-A2-001

A2型题(案例分析) | 应用 | 正选题 | 难度0.54 | 📖 P74-P77

某医院骨科针对"术后感染率偏高"的问题成立了一个由骨科医生、护士、院感专员组成的团队，设定目标在3个月内将感染率降低50%。这个团队属于？

- A. 多学科团队(MDT)
- B. 问题解决型团队 ☒
- C. 虚拟医疗团队
- D. 自我管理型团队
- E. 教学查房团队

正确答案：B

💡 针对特定问题（术后感染率）成立、有明确目标和时限的跨角色团队，是典型的问题解决型团队。

⚠️ 易错点：可能将问题解决型团队与MDT混淆。MDT是针对患者诊疗的多学科协作，问题解决型团队针对质量改进。

---

## 102. YHGT-Ch5-A2-002

A2型题(案例分析) | 应用 | 正选题 | 难度0.52 | 📖 P78-P80

一个由北京、上海、广州三地专家组成的远程会诊团队，通过视频会议系统讨论疑难病例。该团队的沟通最可能面临的挑战是？

- A. 成员人数过多导致决策困难
- B. 面对面交流过于频繁导致效率低下
- C. 团队成员学科背景单一
- D. 远程沟通中的信任缺失和信息延迟 ☒
- E. 缺乏专业知识和临床经验

**正确答案：D**

💡 虚拟医疗团队（跨地域远程协作）的核心挑战是信任缺失、信息延迟和文化差异。视频会议不能完全替代面对面沟通。

⚠️ 易错点：可能低估远程沟通中信任建立的难度。

---

### 103. YHGT-Ch5-A2-003

**A2型题(案例分析)** | 应用 | 正选题 | 难度0.56 | 📖 P71-P73

一位医生因医疗纠纷被投诉，在调查处理过程中，中国医师协会能够发挥的最主要作用是？

- A. 直接撤销患者的投诉
- B. 代表卫生行政部门作出行政裁决
- C. 提供行业角度的专业意见和权益维护 ☒
- D. 替代法院作出民事判决
- E. 对医生进行停职处分

**正确答案：C**

💡 医学协会的职能包括行业自律和权益维护，可在调查中提供专业意见，帮助公正处理。协会不是执法机构。

⚠️ 易错点：可能将协会职能与行政或司法职能混淆。

---

### 104. YHGT-Ch5-A2-004

**A2型题(案例分析)** | 理解 | 正选题 | 难度0.5 | 📖 P74-P77

某医院肿瘤中心的多学科团队(MDT)每周讨论一次疑难病例。与问题解决型团队相比，MDT最主要的区别在于？

- A. MDT聚焦于患者个体诊疗方案制定，而非质量改进项目 ☒
- B. MDT成员人数更少

- C. MDT不需要定期开会
- D. MDT只涉及外科医生
- E. 两者完全相同没有区别

**正确答案：A**

💡 MDT核心是为患者个体制定综合诊疗方案，问题解决型团队针对的是系统或流程的质量改进。两者目标、产出不同。

⚠️ 易错点：可能将两者混为同一概念。

## 105. YHGT-Ch5-A2-005

**A2型题(案例分析)** | 理解 | 正选题 | 难度0.52 | 📖 P78-P80

跨地区远程会诊中，专家A的意见未被当地医院采纳，专家A感到不满并在工作群中批评当地团队。从虚拟医疗团队沟通角度，这一问题的核心是？

- A. 远程会诊技术平台不够先进
- B. 专家A的医学水平不高
- C. 当地医院的设备条件太差
- D. 虚拟团队中信任缺失和沟通规范不健全 ☒
- E. 应该取消远程会诊制度

**正确答案：D**

💡 虚拟医疗团队的核心挑战是信任缺失——远程专家和当地团队之间缺乏面对面建立的信任基础。这需要通过明确的沟通规范和关系建设来弥补。

⚠️ 易错点：可能归因于技术或个人因素而忽略组织沟通层面的问题。

## 106. YHGT-Ch5-A2-006

**A2型题(案例分析)** | 理解 | 正选题 | 难度0.6 | 📖 P71-P72

广义的医方主体不仅包括临床一线医务人员，还包括医疗机构、医学协会和医疗团队。这种广义理解对医患沟通实践最重要的意义是？

- A. 明确了个人不需要对沟通质量负责
- B. 认识到医患沟通是一个涵盖组织层面的系统工程 ☒
- C. 弱化了临床医生的沟通责任
- D. 将沟通责任完全转移给管理层
- E. 否定了个人沟通技能的重要性

正确答案：B

💡 广义理解将沟通从"医生-患者"的个人层面扩展到组织层面，有助于系统性地改善医患沟通。但不意味着个人可以推卸责任。

⚠️ 易错点：可能将广义理解错误地等同于责任分散。

## 107. YHGT-Ch5-A2-007

A2型题(案例分析) | 应用 | 正选题 | 难度0.52 | 📖 P71-P73

一位外科医生在手术前要求所有参与人员暂停手中工作，共同核对患者信息、手术部位和手术方式。这体现了什么？

- A. 医生个人习惯，不是制度要求
- B. 浪费时间的不必要流程
- C. 仅适用于复杂手术
- D. 手术安全核查制度的规范执行和团队沟通意识 ☒
- E. 对团队成员的不信任

正确答案：D

💡 术前暂停(pause)共同核查是手术安全核查制度的规范要求，也是医方团队内部沟通的重要形式——体现的是制度执行和团队协作意识。

⚠️ 易错点：可能将制度执行视为个人习惯或不必要流程。

## 108. YHGT-Ch5-B1-001a

B1型题(匹配) | 记忆 | 正选题 | 难度0.72 | 📖 P74-P80

(共用选项：A.多学科团队 B.问题解决型团队 C.虚拟医疗团队 D.自我管理型团队 E.层级制团队) 肿瘤患者的治疗方案由肿瘤内科、外科、放疗科、病理科等专家共同讨论制定，这属于？

- A. 多学科团队 ☒
- B. 问题解决型团队
- C. 虚拟医疗团队
- D. 自我管理型团队
- E. 层级制团队

正确答案：A

💡 MDT(Multi-Disciplinary Team)的特点是不同专科专家共同为患者制定个体化治疗方案，典型应用于肿瘤诊疗。

⚠ 易错点：可能将MDT与问题解决型团队混淆。MDT关注患者诊疗，问题解决型团队关注质量改进。

---

## 109. YHGT-Ch5-B1-001b

B1型题(匹配) | 理解 | 正选题 | 难度0.68 | 📖 P74-P80

(共用选项同上) 医院成立"降低门诊候诊时间"专项工作组，由门诊医生、护士、挂号处人员、信息科人员组成，这属于？

- A. 多学科团队
- B. 问题解决型团队 ☒
- C. 虚拟医疗团队
- D. 自我管理型团队
- E. 层级制团队

**正确答案：B**

💡 针对特定问题（候诊时间）成立、有明确目标、由不同角色组成的改进团队，属于问题解决型团队。

⚠ 易错点：可能将问题解决型团队与MDT混淆。MDT针对患者个体诊疗。

---

## 110. YHGT-Ch5-B1-001c

B1型题(匹配) | 理解 | 正选题 | 难度0.66 | 📖 P74-P80

(共用选项同上) 疫情期间，多个城市的ICU专家通过在线平台每日讨论危重症患者救治方案，这属于？

- A. 多学科团队
- B. 问题解决型团队
- C. 虚拟医疗团队 ☒
- D. 自我管理型团队
- E. 层级制团队

**正确答案：C**

💡 跨地域专家通过信息技术平台进行远程协作，是虚拟医疗团队的典型形式。

⚠ 易错点：可能将其简单归为MDT而忽略其"远程/虚拟"的本质特征。

---



## 111. YHGT-Ch5-J-001

判断题 | 理解 | 正选题 | 难度0.72 | P74-P80

问题解决型团队通常由来自不同科室的专家组成，人数不限，主要针对患者个体诊疗方案的制定。

- A. 正确
- B. 错误 ☒

正确答案：B

💡 该描述混淆了问题解决型团队与MDT。问题解决型团队通常5-12人、针对质量改进项目，MDT由不同科室专家组成、针对患者诊疗。

⚠️ 易错点：容易将问题解决型团队与MDT的特征混淆。

## 112. YHGT-Ch5-X-001

X型题(多选) | 记忆 | 正选题 | 难度0.6 | P74-P80

医疗团队的主要类型包括哪些？（多选）

- A. 多学科团队(MDT) ☒
- B. 问题解决型团队 ☒
- C. 虚拟医疗团队 ☒
- D. 自我管理型团队 ☒
- E. 独立执业型团队

正确答案：ABCD

💡 医疗团队主要类型分为四类：MDT、问题解决型、虚拟团队、自我管理型。E不是标准分类。

⚠️ 易错点：可能不熟悉标准分类或混淆独立执业与团队概念。

## 113. YHGT-Ch5-X-002

X型题(多选) | 理解 | 正选题 | 难度0.56 | P78-P80

虚拟医疗团队面临的主要挑战包括哪些？（多选）

- A. 远程沟通导致的信息延迟 ☒
- B. 面对面交流时间过多影响效率
- C. 跨地域文化差异 ☒

- D. 团队信任的建立困难 ☒
- E. 技术平台和数字鸿沟 ☒

**正确答案：ACDE**

💡 虚拟团队挑战包括信息延迟(A)、文化差异(C)、信任缺失(D)、技术障碍(E)。B与虚拟团队特点相反，远程团队缺乏面对面交流。

⚠️ 易错点：可能将虚拟团队的优势（不需要面对面）误认为问题。

## 114. YHGT-Ch5-X-003

**X型题(多选)** | 理解 | 正选题 | 难度0.5 | 📖 P74-P80

**关于问题解决型团队，以下描述正确的是？（多选）**

- A. 通常由5-12人组成 ☒
- B. 主要针对患者个体诊疗方案
- C. 针对特定质量问题或改进项目 ☒
- D. 存在决策速度较慢的局限性 ☒
- E. 成员通常来自同一科室或部门 ☒

**正确答案：ACDE**

💡 问题解决型团队特征：5-12人(A)，针对质量改进(C)，决策较慢(D)，同部门成员(E)。B描述的是MDT的特征。

⚠️ 易错点：可能将问题解决型团队的特征与MDT混淆。

## 第六章 医院诊疗的医患沟通

### 115. YHGT-Ch6-A1-001

**A1型题** | 记忆 | 正选题 | 难度0.74 | 📖 P85-P90

**门诊工作的特点不包括？**

- A. 患者量大、就诊时间短
- B. 病种复杂多样
- C. 连续性相对较差
- D. 每位患者有充足的沟通时间 ☒
- E. 医生需要在短时间内快速判断

**正确答案：D**

💡 门诊特点是量大、时间短、病种杂、连续性差。D与门诊实际情况相反，门诊恰恰面临沟通时间不足的挑战。

⚠️ 易错点：可能将理想化的门诊沟通与实际情况混淆。

---

## 116. YHGT-Ch6-A1-002

A1型题 | 记忆 | 正选题 | 难度0.7 | 📖 P90-P95

急诊患者的典型特征不包括？

- A. 病情平稳、有充足沟通时间 ☒
- B. 病情急重、变化迅速
- C. 患者和家属情绪焦虑紧张
- D. 家属人数多、期望值高
- E. 需要在短时间内做出决策

正确答案：A

💡 急诊患者特征是病情急重、情绪焦虑、家属多、决策紧迫。A与急诊特征完全相反。

⚠️ 易错点：可能将门诊和急诊的患者特征混淆。

---

## 117. YHGT-Ch6-A1-003

A1型题 | 记忆 | 正选题 | 难度0.76 | 📖 P95-P100

手术环节沟通的三个阶段依次是？

- A. 术中沟通、术前谈话、术后随访
- B. 术后沟通、术前沟通、术中沟通
- C. 术前谈话、术中告知、术后沟通 ☒
- D. 手术预约、麻醉评估、出院指导
- E. 知情同意、费用告知、出院小结

正确答案：C

💡 手术环节沟通分三阶段：术前谈话（方案/风险/知情同意）、术中告知（术中发现/变更）、术后沟通（结果/康复/随访）。

⚠️ 易错点：可能将手术流程与沟通流程混淆。

---

## 118. YHGT-Ch6-A2-001

一位门诊医生上午需接诊40位患者。面对如此大的门诊量，最合理的沟通策略是？

- A. 省略所有非必要沟通，只开检查和处方
- B. 在有限时间内抓住重点，兼顾效率和人文关怀 ☒
- C. 建议患者全部转至急诊以分流
- D. 延长每位患者的沟通时间至半小时
- E. 让实习医生独立接诊以分担工作量

正确答案：B

💡 门诊量大时，医生需在效率和质量间取得平衡——抓住核心问题、使用结构化沟通、在关键节点给予人文关注。

⚠️ 易错点：可能认为门诊量大时只能牺牲质量追求效率或相反。

## 119. YHGT-Ch6-A2-002

一位急性心肌梗死患者被送至急诊，家属情绪非常激动且不断质问“为什么不马上手术”。急诊医生最合适的回应是？

- A. "家属请不要干扰抢救，在外面等着"
- B. "手术需要时间准备，你们先交费"
- C. "我们正在全力抢救，我会在完成紧急处理后立即向你们说明情况" ☒
- D. "这是医院的规定，我不能现在解释"
- E. "如果你们不满意，可以去其他医院"

正确答案：C

💡 急诊沟通核心是在紧急处置的同时给家属一个“时间承诺”——告知当前正在做什么、何时会沟通详情，平衡紧急救治与家属情绪安抚。

⚠️ 易错点：可能认为急诊只需要专注抢救不需要沟通。

## 120. YHGT-Ch6-A2-003

患者手术中发现术前未预料到的情况需要扩大切除范围，术中告知家属时最核心的原则是？

- A. 为避免家属焦虑，不告知扩大切除的决定
- B. 由护士代为告知即可

- C. 等手术完全结束后再统一告知
- D. 客观说明术中发现、扩大切除的必要性和风险，征求同意 
- E. 直接扩大切除，术后再补签知情同意书

**正确答案：D**

💡 术中告知的核心是客观说明新发现、解释扩大切除的必要性和风险、征求家属知情同意。术中重大变更必须告知。

⚠️ 易错点：可能认为"术中紧急"可以跳过知情同意环节。

## 121. YHGT-Ch6-A2-004

**A2型题(案例分析)** | 理解 | 正选题 | 难度0.62 | 📖 P85-P90

门诊医生面对一位复诊高血压患者，时间只有5分钟。最有效的沟通策略是？

- A. 全面重新问诊以不漏掉任何细节
- B. 仅调整药物不做任何解释
- C. 聚焦关键指标变化和依从性，简明沟通 
- D. 建议患者改挂专家号以获得更长时间
- E. 告知患者下次带齐所有检查再来

**正确答案：C**

💡 复诊+时间有限的场景下，聚焦关键变化（血压控制、药物反应、生活方式依从性）的简明沟通最高效。

⚠️ 易错点：可能在有限时间内试图全覆盖或完全放弃沟通。

## 122. YHGT-Ch6-A2-005

**A2型题(案例分析)** | 理解 | 正选题 | 难度0.6 | 📖 P95-P100

患者术前在知情同意书上签字后，临上手术台前突然说"医生，我还是有点害怕"。此时医生最合适的不包括？

- A. 暂停片刻，用简短话语安抚患者情绪
- B. 告知麻醉医生即将开始，让患者放松
- C. 告知已签字就不能反悔 
- D. 握住患者的手或轻拍肩膀给予非语言支持
- E. 简单确认患者的担忧并给予回应

**正确答案：C**

💡 患者术前焦虑是正常的，已签署同意书不等于不能表达情绪。"不能反悔"不仅无效还可能增加患者恐惧。

⚠️ 易错点：可能认为签署知情同意后就"一切已成定局"。

## 123. YHGT-Ch6-A3-001

A3型题(病例串) | 分析 | 正选题 | 难度0.46 | 📖 P85-P118

(案例) 老年患者急诊入院，儿子女儿同时在场但意见分歧：儿子要求"不惜代价全力抢救"，女儿认为"不要折腾老人"。

从多维度分析，医生此时最恰当的综合处理策略是？

- A. 按照儿子的意见全力抢救
- B. 按照女儿的意见采取保守治疗
- C. 与家属沟通病情预后，协助达成共识并关注患者本人意愿 ☒
- D. 告知家属意见不统一，医院暂不处理
- E. 让家属自行商量，医生回避参与

**正确答案：C**

💡 家属意见分歧时医生的角色是提供专业信息帮助家属做出知情决策，同时关注患者本人意愿。不是选边站队或回避。

⚠️ 易错点：可能认为选择强势一方或回避矛盾更简单。

## 124. YHGT-Ch6-A3-002

A3型题(病例串) | 分析 | 正选题 | 难度0.42 | 📖 P85-P118

(同案例) 在与家属沟通过程中，女儿提到"邻居说了，送ICU就是受罪"。医生从健康知识宣教和危重症沟通角度，最应该？

- A. 告知女儿"不要听邻居的"
- B. 通俗解释ICU监护的必要性及获益，纠正错误认知 ☒
- C. 告知邻居部分说法需专业核实
- D. 建议女儿去问邻居是否有医学背景
- E. 忽略该说法继续讨论其他问题

**正确答案：B**

💡 面对公众的错误健康认知，医生的角色是提供专业、通俗的解释以纠正错误信息，而非简单否定或回避。健康知识宣教是医生的职责。

⚠ 易错点：可能对非专业信息来源不屑一顾而简单否定。

## 125. YHGT-Ch6-A3-003

A3型题(病例串) | 分析 | 正选题 | 难度0.44 | 📖 P85-P118

(案例串题) 68岁男性因急性腹痛入院，初步诊断肠梗阻。医生建议急诊手术，患者儿子签署了知情同意书。术中医生发现同时存在肠道肿瘤，需扩大切除范围。

Q1：术中告知时，家属情绪激动拒绝扩大切除。从沟通和法律角度，最恰当的处理是？

- A. 听从家属意见，不做扩大切除
- B. 不再沟通，直接按原计划结束手术
- C. 暂停非紧急步骤，再次沟通说明扩大切除的医学必要性和不做的风险，努力争取理解 ✓
- D. 转告家属如果不同意就转院
- E. 让护士代为签署扩大切除知情同意书

正确答案：C

💡 术中遇到新情况需要扩大手术范围时，必须再次取得知情同意。但沟通需要耐心 and 技巧——暂停非紧急步骤、说明必要性和风险。紧急情况危及生命时可依法先行处理。

⚠ 易错点：可能认为家属已签字就不需要再沟通，或认为家属拒绝就必须停止。

## 126. YHGT-Ch6-A3-004

A3型题(病例串) | 应用 | 正选题 | 难度0.52 | 📖 P85-P118

(同案例) 术后患者恢复良好，但家属对术中“临时变更手术方案”仍有疑问。从冲突沟通角度，术后沟通应优先？

- A. 强调术前已签署知情同意书包含“术中可能扩大范围”条款
- B. 告知家属如果不满意可以走法律程序
- C. 避免提及术中变更以减少矛盾
- D. 诚实解释术中具体发现、决策依据，并倾听家属的疑虑 ✓
- E. 由科室主任全权处理，经治医生不再参与沟通

正确答案：D

💡 术后沟通应以诚实守信和换位思考为核心——客观解释术中决策依据，倾听并回应家属疑虑。仅依赖法律条款(A)或回避(C)都不是建设性沟通。

⚠ 易错点：可能只强调“法律上没问题”而忽略情感沟通。

## 127. YHGT-Ch6-X-001

X型题(多选) | 记忆 | 正选题 | 难度0.62 | 📖 P85-P90

门诊工作的特点包括哪些？（多选）

- A. 患者量大、就诊时间短 ☒
- B. 病种复杂多样 ☒
- C. 医生与患者的连续性相对较差 ☒
- D. 每位患者有充足的沟通时间
- E. 医生需要在短时间内做出判断 ☒

正确答案：ABCE

💡 门诊特点包括患者量大、时间短、病种杂、连续性差、需快速判断。D与门诊现状相反。

⚠️ 易错点：可能将理想化的门诊沟通与现实情况混淆。

## 128. YHGT-Ch6-X-002

X型题(多选) | 记忆 | 正选题 | 难度0.64 | 📖 P90-P95

急诊患者的典型特征包括哪些？（多选）

- A. 病情急重、变化迅速 ☒
- B. 患者和家属情绪焦虑紧张 ☒
- C. 家属人数多、期望值高 ☒
- D. 需要在短时间内做出决策 ☒
- E. 就诊环境安静、沟通时间充裕

正确答案：ABCD

💡 急诊特征包括病情急重(A)、情绪焦虑(B)、家属多期望高(C)、决策紧迫(D)。E描述的是非急诊的检查环境。

⚠️ 易错点：可能将急诊与门诊环境混淆。

## 第七章 特殊人群的沟通

### 129. YHGT-Ch7-A1-001

A1型题 | 记忆 | 正选题 | 难度0.72 | 📖 P105-P110

儿科患者家长常见的心理特点不包括？



- A. 对患儿病情的过度焦虑
- B. 因未能保护好孩子而产生的自责
- C. 对孩子过度保护倾向
- D. 对医护人员的完全信任和理性冷静 ☒
- E. 对治疗效果的不合理高期望

**正确答案：D**

💡 儿科家长常见心理特点包括焦虑(A)、自责(B)、过度保护(C)、期望过高(E)。D描述的是理想状态，实际中家长往往因焦虑而难以完全理性。

⚠️ 易错点：可能将理想中的家长态度与现实混淆。

---

## 130. YHGT-Ch7-A1-002

**A1型题** | 记忆 | 正选题 | 难度0.74 | 📖 P110-P113

**"交换对象沟通"是指？**

- A. 两个医生之间交换患者信息
- B. 护士与医生之间的信息交换
- C. 与患者家属或监护人而非患者本人直接进行沟通 ☒
- D. 患者在不同医院之间的转诊沟通
- E. 使用翻译器与外国患者沟通

**正确答案：C**

💡 交换对象沟通指因患者本人无法直接沟通（儿童、昏迷、痴呆、精神障碍等），而以家属或监护人为沟通对象。

⚠️ 易错点：可能将其理解为医生之间的信息交换。

---

## 131. YHGT-Ch7-A1-003

**A1型题** | 记忆 | 正选题 | 难度0.68 | 📖 P113-P118

**危重症患者沟通中的常见问题不包括？**

- A. 短时间内信息过载
- B. 患者和家属情绪稳定、配合度高 ☒
- C. 家属决策困难
- D. 沟通时间紧迫
- E. 情绪障碍影响理性决策

正确答案：B

💡 危重症沟通常见问题包括信息过载(A)、决策困难(C)、时间紧迫(D)、情绪障碍(E)。B描述的是理想状态而非危重症的实际情境。

⚠️ 易错点：可能忽略了危重症情境下家属的情绪波动和决策压力。

## 132. YHGT-Ch7-A2-001

A2型题(案例分析) | 应用 | 正选题 | 难度0.56 | 📖 P105-P110

一位5岁白血病患儿的母亲在医生告知化疗方案时反复询问“有没有更好的办法”“会不会影响将来生育”，并不断查阅手机信息。该母亲的行为主要反映了？

- A. 对医务人员的不信任和敌意
- B. 儿科家长常见的焦虑和过高期望心理 ☒
- C. 医学知识丰富，希望参与共同决策
- D. 正常的理性决策过程，无需特殊关注
- E. 需要转诊到更高级别医院

正确答案：B

💡 反复询问、查阅信息、担忧长远影响是儿科家长焦虑和期望过高的典型表现。这需要医生给予更多耐心和信息支持，而非视为不信任。

⚠️ 易错点：可能将家长焦虑误解为对医生的不信任或敌意。

## 133. YHGT-Ch7-A2-002

A2型题(案例分析) | 应用 | 正选题 | 难度0.6 | 📖 P110-P113

一位阿尔茨海默病晚期患者因肺炎入院治疗。医生在制定治疗方案时，最恰当的沟通对象是？

- A. 仅与患者本人沟通以确保自主权
- B. 不与任何人沟通，直接按常规方案治疗
- C. 与患者家属/法定监护人沟通，同时关注患者非语言反应 ☒
- D. 让护士全权负责沟通事宜
- E. 等待患者意识恢复后再进行沟通

正确答案：C

💡 阿尔茨海默病晚期患者无知情同意能力，应采用交换对象沟通——与家属/监护人沟通，同时通过非语言方式关注患者舒适度。

⚠️ 易错点：可能机械坚持“必须与患者本人沟通”的原则而忽略患者实际能力。

---

## 134. YHGT-Ch7-A2-003

A2型题(案例分析) | 应用 | 正选题 | 难度0.54 | 📖 P113-P118

ICU中一位危重患者的家属在医生说明病情后表现出愤怒："你们为什么不早点发现！"此时医生最恰当的方法是？

- A. 反驳家属，说明医院已经尽了最大努力
- B. 保持沉默，等待家属冷静下来
- C. 请保安将情绪激动的家属带离
- D. 直接告知治疗方案，忽略家属情绪
- E. 先共情回应家属情绪，再客观解释病情发展过程 ☒

**正确答案：E**

💡 危重症沟通中家属的愤怒往往是焦虑和恐惧的外在表现。应先共情回应情绪（"我理解您的着急"），再解释事实，而非对抗或回避。

⚠️ 易错点：可能将家属情绪反应理解为对医疗的否定而采取防御姿态。

---

## 135. YHGT-Ch7-A2-004

A2型题(案例分析) | 应用 | 正选题 | 难度0.58 | 📖 P105-P110

一位儿科医生在接诊时注意到患儿母亲眼眶红肿、说话时声音颤抖。医生在问诊前最合适的做法是？

- A. 先给予简短的情感支持，如"我看您很担心孩子，我们一起来看看" ☒
- B. 直接开始询问患儿的症状和体征
- C. 建议母亲先去看心理科
- D. 告诉母亲"不要哭，哭解决不了问题"
- E. 让母亲到诊室外等候，单独检查患儿

**正确答案：A**

💡 识别并回应家长的情绪是儿科沟通的首要步骤。简短共情可建立信任，再进入病史采集。

⚠️ 易错点：可能认为应直接进入病史采集以提高效率。

---

## 136. YHGT-Ch7-A2-005

A2型题(案例分析) | 理解 | 正选题 | 难度0.56 | 📖 P113-P118

ICU患者家属在探视时反复询问护士“他什么时候能醒”“是不是越来越严重了”，并频繁致电医生办公室。这反映了危重症家属沟通中的什么问题？

- A. 家属对医疗方案有严重质疑
- B. 家属需要转院治疗
- C. 护士和医生沟通不到位
- D. 信息不确定感导致的焦虑和过度寻求信息行为 ☒
- E. 家属精神异常需要心理干预

正确答案：D

💡 危重症情境下家属因信息不确定而反复寻求确认是正常的心理反应，需要的是定期的信息更新和情感支持，而非视为异常或质疑。

⚠️ 易错点：可能将家属的正常焦虑误解为对医疗的不信任或精神问题。

## 137. YHGT-Ch7-A2-006

A2型题(案例分析) | 理解 | 正选题 | 难度0.56 | 📖 P113-P118

面对伴有沟通障碍的危重症患者（如气管插管后无法言语），最有效的辅助沟通方式是？

- A. 使用写字板、图片卡、眨眼示意等替代沟通方式 ☒
- B. 等待患者拔除插管后再沟通
- C. 完全依赖家属代为沟通
- D. 减少与患者的沟通次数
- E. 仅通过监护仪数据判断患者状态

正确答案：A

💡 面对沟通障碍患者，应积极寻找替代沟通方式（写字/图片/点头眨眼等），而非放弃沟通或完全依赖第三方。

⚠️ 易错点：可能认为沟通困难就减少沟通。

## 138. YHGT-Ch7-A2-007

A2型题(案例分析) | 理解 | 正选题 | 难度0.58 | 📖 P105-P110

儿科门诊医生面对一位反复带孩子就诊的焦虑母亲，其孩子实为普通感冒。最合适的综合沟通策略是？

- A. 告知母亲“孩子没事，不用总往医院跑”
- B. 给母亲开一些抗焦虑药物

- C. 肯定母亲的关心+解释感冒自然病程+给出明确的"就医指征"指导 ☒
- D. 建议母亲去心理科就诊
- E. 减少解释以缩短就诊时间

**正确答案：C**

💡 对焦虑的儿科家长，有效策略=共情肯定+医学知识普及+可操作指导（如"什么时候需要再来"），而非简单打发或过度医疗化。

⚠️ 易错点：可能对"频繁就诊"产生厌烦情绪而简单打发。

## 139. YHGT-Ch7-A3-001

**A3型题(病例串)** | 应用 | 正选题 | 难度0.54 | 📖 P105-P118

（案例串题）5岁患儿因重症肺炎入住PICU，患儿父母每日在病房外守候，不断询问医护人员病情。第3天，患儿母亲突然在探视时情绪崩溃大哭。

**Q1：从儿科重症沟通角度，护士最合适的即时反应是？**

- A. 告知母亲探视时间有限，请控制情绪
- B. 暂停探视流程，给予情感支持和简短共情 ☒
- C. 通知保安将母亲带离病房
- D. 加速完成护理操作以减少接触时间
- E. 告诉母亲"孩子情况很稳定，不用担心"

**正确答案：B**

💡 儿科重症家长的情绪崩溃需要即时共情和情感支持，而非冷漠对待。暂停非紧急操作给予关怀是恰当做法。但注意"孩子很稳定"这样的空泛安慰可能不恰当。

⚠️ 易错点：可能认为PICU的工作重点是护理操作而非家属情绪。

## 140. YHGT-Ch7-A3-002

**A3型题(病例串)** | 应用 | 正选题 | 难度0.5 | 📖 P105-P118

（同案例）患儿病情稳定转出PICU后，母亲告诉医生"在ICU那几天我每天失眠，就怕接到医院电话"。从患者家属心理和沟通角度，这反映的核心问题是？

- A. 母亲有焦虑障碍需要药物治疗
- B. 医院提供的医疗信息不够充分
- C. 母亲性格过于敏感
- D. 重症患儿家属普遍存在的焦虑和信息不确定感 ☒
- E. ICU的探视制度不够人性化

正确答案：D

💡 PICU家属的焦虑和失眠是正常的心理应激反应，反映的是重症情境下的信息不确定感和无力感——而非个人心理疾病或医院制度问题。定期信息更新是缓解焦虑的关键。

⚠️ 易错点：可能将正常应激反应病理化或过度归因于个人因素。

## 141. YHGT-Ch7-J-001

判断题 | 理解 | 正选题 | 难度0.74 | 📖 P110-P113

对于无知情同意能力的患者（如昏迷、严重痴呆），医生可以采用交换对象沟通方式，与患者家属或法定监护人进行沟通和知情同意。

A. 正确 ☒

B. 错误

正确答案：A

💡 交换对象沟通是正确的临床做法，适用于患者本人无知情同意能力的情况，符合伦理和法律规范。

⚠️ 易错点：可能认为必须等到患者恢复意识才能沟通。

## 142. YHGT-Ch7-X-001

X型题(多选) | 记忆 | 正选题 | 难度0.62 | 📖 P105-P110

儿科患者家长常见的心理特点包括哪些？（多选）

A. 对患儿病情的过度焦虑和担忧 ☒

B. 因未能保护好孩子而产生的自责 ☒

C. 对孩子过度保护和溺爱倾向 ☒

D. 对医疗过程的绝对信任和完全配合

E. 对治疗效果的不合理高期望 ☒

正确答案：ABCE

💡 儿科家长心理特点包括焦虑(A)、自责(B)、过度保护(C)、期望过高(E)。D是理想化状态，现实中家长常有疑虑和担忧。

⚠️ 易错点：可能理想化家长态度而忽略真实心理反应。

## 143. YHGT-Ch7-X-002

X型题(多选) | 理解 | 正选题 | 难度0.6 | 📖 P110-P113

以下哪些情况适合采用交换对象沟通？（多选）

- A. 患儿为3岁的幼儿 ☒
- B. 患者处于昏迷状态 ☒
- C. 患者为重度阿尔茨海默病患者 ☒
- D. 患者为急性精神病发作期 ☒
- E. 成年患者意识清醒且具有完全民事行为能力

正确答案：ABCD

💡 交换对象沟通适用于患者本人无法有效沟通的情况：儿童(A)、昏迷(B)、痴呆(C)、精神障碍(D)。意识清醒的成人(E)不需要交换对象。

⚠️ 易错点：可能对所有患者都采用交换对象沟通而忽略患者自主沟通能力。

## 144. YHGT-Ch7-X-003

X型题(多选) | 理解 | 正选题 | 难度0.56 | 📖 P113-P118

危重症患者沟通中的常见问题包括哪些？（多选）

- A. 短时间内信息过载 ☒
- B. 家属决策困难 ☒
- C. 情绪障碍影响理性决策 ☒
- D. 沟通时间紧迫 ☒
- E. 医患双方有充足时间从容讨论

正确答案：ABCD

💡 危重症沟通常见问题包括信息过载(A)、决策困难(B)、情绪障碍(C)、时间紧迫(D)。E与危重症情境相反。

⚠️ 易错点：可能忽略危重症沟通的特殊挑战。

## 第八章 医患冲突中的沟通

### 145. YHGT-Ch8-A1-001

A1型题 | 记忆 | 正选题 | 难度0.7 | 📖 P144-P148

应对医患冲突的沟通原则不包括？

- A. 平等尊重原则
- B. 诚实守信原则
- C. 换位思考原则
- D. 依法处置原则
- E. 优先维护医院声誉原则 ☒

**正确答案：E**

💡 应对冲突的六大原则是：平等尊重、诚实守信、换位思考、适度体语、公正合理、依法处置。E以维护医院声誉为优先不符合以患者为中心和公正合理原则。

⚠️ 易错点：可能将机构利益保护误认为冲突处理原则。

---

## 146. YHGT-Ch8-A1-002

**A1型题** | 记忆 | 正选题 | 难度0.74 | 📖 P148-P150

**医患冲突中语言沟通的主要方式不包括？**

- A. 协商沟通
- B. 解释说明
- C. 命令威胁 ☒
- D. 道歉表达
- E. 调解斡旋

**正确答案：C**

💡 冲突中语言沟通方式包括协商、解释、道歉、调解等建设性方式。命令威胁是破坏性沟通，不仅不是主要方式，还会激化冲突。

⚠️ 易错点：可能将冲突中常见的对抗性言语误认为正式沟通方式。

---

## 147. YHGT-Ch8-A1-003

**A1型题** | 记忆 | 正选题 | 难度0.66 | 📖 P150-P153

**医患冲突人民调解，当事人提出调解申请后，人民调解委员会完成调解的时限为？**

- A. 5个工作日
- B. 15个工作日
- C. 7个工作日
- D. 30个工作日 ☒
- E. 60个工作日



**正确答案：D**

💡 根据规定，人民调解委员会应在受理后30个工作日内完成调解。注意与行政调解的5个工作日受理时限区分。

⚠️ 易错点：容易将人民调解的30个工作日完成时限与行政调解的5个工作日受理时限混淆。

## 148. YHGT-Ch8-A1-004

**A1型题** | 记忆 | 正选题 | 难度0.68 | 📖 P153-P155

**医患双方申请行政调解，卫生行政部门做出是否受理决定的时限为？**

- A. 5个工作日 ☒
- B. 10个工作日
- C. 15个工作日
- D. 30个工作日
- E. 收到申请当日

**正确答案：A**

💡 卫生行政部门收到行政调解申请后，应在5个工作日内做出是否受理的决定。注意区分：行政调解是5个工作日受理，人民调解是30个工作日完成。

⚠️ 易错点：容易将行政调解受理时限与人民调解完成时限混淆。

## 149. YHGT-Ch8-A1-005

**A1型题** | 理解 | 正选题 | 难度0.6 | 📖 P144-P148

**换位思考原则在医患冲突沟通中的核心要求是？**

- A. 完全认同患方的所有诉求
- B. 从患者的角度理解其情绪和需求，但不等于放弃专业立场 ☒
- C. 让患方完全接受医方的解释
- D. 回避所有可能导致冲突的话题
- E. 由第三方辅助参与医患直接沟通

**正确答案：B**

💡 换位思考是理解患者处境和感受，但不等于放弃专业判断或完全认同其诉求。理解对方不等于同意对方。

⚠️ 易错点：可能将换位思考误解为无原则的妥协或让步。

---

## 150. YHGT-Ch8-A2-001

A2型题(案例分析) | 应用 | 正选题 | 难度0.52 | 📖 P144-P148

一位患者因候诊时间过长而大声抱怨"等了2小时就看5分钟"，并指责"你们医生根本不在乎病人"。医生最恰当的回答是？

- A. "我们也很忙，您看看外面还有多少人在排队"
- B. "这是医院制度，我也没办法"
- C. "您要是不满意可以去投诉"
- D. "我理解您等候很辛苦，我为候诊时间过长向您道歉，现在我会认真为您看诊" ☒
- E. 保持沉默，不与患者争辩

**正确答案：D**

💡 运用冲突原则：先换位思考（理解等候辛苦）+诚实守信（承认候诊时间长）+道歉+提出解决方案。不推卸不对抗。

⚠️ 易错点：可能采取防御姿态解释客观原因，忽略先承认和共情。

---

## 151. YHGT-Ch8-A2-002

A2型题(案例分析) | 应用 | 正选题 | 难度0.55 | 📖 P150-P153

患者因术后并发症与医院产生纠纷，双方协商未果。患者首先可以选择的第三方调解途径是？

- A. 直接向法院提起诉讼
- B. 向卫生行政部门申请行政复议
- C. 向人民调解委员会（医调委）申请调解 ☒
- D. 通过媒体曝光施加压力
- E. 只能继续与医院协商

**正确答案：C**

💡 根据"调解优先"原则，人民调解（医调委）是首选的第三方调解途径，具有免费、便捷的特点。调解不成可再走行政调解或诉讼。

⚠️ 易错点：可能跳过调解环节直接选择诉讼或媒体曝光。

---

## 152. YHGT-Ch8-A2-003

A2型题(案例分析) | 应用 | 正选题 | 难度0.5 | 📖 P144-P148

医疗纠纷发生后，医务科工作人员在与患方沟通时注意到患者家属身体前倾、双拳紧握、语速加快。根据适度体语原则，此时最合适的做法是？

- A. 保持适当距离，使用平和语气，避免激化情绪 ☒
- B. 靠近患者家属以示亲近
- C. 交叉双臂、保持沉默
- D. 提高音量以显示权威
- E. 转身离开，暂时回避

正确答案：A

💡 对方体语显示愤怒升级信号时，应保持安全距离、使用平和语气、避免动作夸张激化冲突。适度体语原则强调体态语言要符合场合。

⚠️ 易错点：可能未识别对方的愤怒体语信号而做出不当回应。

## 153. YHGT-Ch8-A2-004

A2型题(案例分析) | 应用 | 正选题 | 难度0.54 | 📖 P144-P148

患者投诉医生“态度生硬”，医院调查后发现医生确实在告知病情时缺乏共情。根据诚实守信原则，医院最恰当的做法是？

- A. 否认医生态度有问题，强调医疗方案正确
- B. 内部批评医生但并不告知患者
- C. 承认沟通方式存在不足，向患者道歉并改进 ☒
- D. 将该医生调离岗位以避免类似投诉
- E. 告知患者“医生性格如此，请多担待”

正确答案：C

💡 诚实守信原则要求承认错误、道歉并改进。回避或否认只会进一步损害信任。承认沟通不足不等于承认医疗过错。

⚠️ 易错点：可能认为承认不足会引发更大的纠纷。

## 154. YHGT-Ch8-A2-005

A2型题(案例分析) | 理解 | 正选题 | 难度0.52 | 📖 P144-P148

患者因术后疼痛控制不佳与护士发生口角，护士说“别人都能忍，就你事多”。该护士违反了哪项冲突沟通原则？

- A. 依法处置原则
- B. 平等尊重原则 ☒
- C. 公正合理原则
- D. 诚实守信原则
- E. 适度体语原则

**正确答案：B**

💡 "别人都能忍，就你事多"是典型的缺乏尊重——以贬低性语言否定患者的主观感受。疼痛是主观体验，不能横向比较。

⚠️ 易错点：可能认为护士只是在"说实话"，忽略了尊重原则的优先性。

---

## 155. YHGT-Ch8-A2-006

**A2型题(案例分析)** | 理解 | 正选题 | 难度0.56 | 📖 P150-P155

患者与医院发生医疗纠纷后，先后经历了院内协商（未果）、人民调解（调解失败）、准备申请行政调解。按照法定程序，行政调解申请应在什么时限内得到是否受理的答复？

- A. 当天答复
- B. 3个自然日
- C. 15个工作日
- D. 5个工作日 ☒
- E. 30个工作日

**正确答案：D**

💡 行政调解受理时限为5个工作日。注意：30个工作日是人民调解的完成时限，不是行政调解受理时限。

⚠️ 易错点：容易将两种调解的时限数值相互混淆。

---

## 156. YHGT-Ch8-A2-007

**A2型题(案例分析)** | 理解 | 正选题 | 难度0.56 | 📖 P144-P148

在处理医疗纠纷时，医务科工作人员对患方说"你们的心情我们非常理解，我们一定会公正处理这件事"。这句话体现了冲突沟通的哪些原则？

- A. 仅体现了依法处置原则
- B. 仅体现了诚实守信原则
- C. 体现了换位思考原则和公正合理原则 ☒

- D. 仅体现了平等尊重原则
- E. 没有体现任何沟通原则

**正确答案：C**

💡 "理解你们的心情"是换位思考，"公正处理"是公正合理原则的承诺。一句话中体现了两个原则。

⚠️ 易错点：可能只看到其中一个原则而忽略另一个。

## 157. YHGT-Ch8-A3-001

**A3型题(病例串)** | 分析 | 正选题 | 难度0.44 | 📖 P144-P155

**(案例)** 患者因手术并发症致残，在医院大厅拉横幅、召集媒体报道。医务科启动应急沟通。从多原则综合分析，在面向媒体的危机沟通中，以下哪项原则组合最为关键？

- A. 仅依法处置——一切走法律程序
- B. 仅诚实守信——全部公开所有细节
- C. 仅换位思考——承认医院全部责任
- D. 仅平等尊重——与患方平等对话
- E. 综合运用诚实守信、依法处置、平等尊重、换位思考四原则 ☒

**正确答案：E**

💡 公共危机场景下的医患冲突需要多原则综合运用，单一原则无法全面应对。诚实守信但不泄露隐私，依法处置但不冷漠，换位思考但不全盘承认。

⚠️ 易错点：可能倾向于单一原则解决复杂问题。

## 158. YHGT-Ch8-A3-002

**A3型题(病例串)** | 分析 | 正选题 | 难度0.4 | 📖 P144-P155

**(同案例)** 事件发生后，医院内部召开紧急会议。医务科建议"等事实查清后再对外发声"，宣传科建议"立即对外发布初步声明"。从危机沟通和信息传播角度，哪个建议更合理？

- A. 医务科建议——必须等全部事实查清
- B. 宣传科建议——但应发布未经核实的信息抢占先机
- C. 两者都不合理——应该保持沉默
- D. 宣传科思路更合理——发布已确认的基本事实并承诺持续更新 ☒
- E. 医务科思路更合理——沉默是最好的危机公关

**正确答案：D**

💡 危机沟通的首因效应要求抢占信息先机——发布已确认的基本事实（非全部细节）+承诺持续更新，既诚实又不失主动。信息真空会被谣言填补。

⚠️ 易错点：可能认为信息不完整就不应发布。

## 159. YHGT-Ch8-A3-003

A3型题(病例串) | 分析 | 正选题 | 难度0.4 | 📖 P144-P155

（案例串题）患者因术后感染与医院产生纠纷。家属在社交媒体发文指控医院“草菅人命”，引发舆情。医院启动危机应对。

Q1：从冲突沟通和危机公关角度，医院回应的最优策略是？

- A. 在社交媒体上逐条反驳家属指控
- B. 保持沉默，等舆情自行平息
- C. 通过法律途径起诉家属诽谤
- D. 删除社交媒体上的相关讨论
- E. 通过官方渠道澄清事实，说明调查进展，承诺公布结果并表达关切 ✓

正确答案：E

💡 社交媒体时代的医疗危机应对遵循：诚实告知已确认事实+主动设置议程（说明正在做什么）+表达关切（共情）+提供后续信息获取渠道。对抗或沉默都会恶化舆情。

⚠️ 易错点：可能倾向于法律对抗或消极回避。

## 160. YHGT-Ch8-A3-004

A3型题(病例串) | 分析 | 正选题 | 难度0.42 | 📖 P144-P155

（同案例）舆情平息后医院内部进行复盘。调查发现：管床医生在术后第2天已注意到感染征象但未及时向上级报告。从多制度角度，这一事件反映了哪些核心制度执行不到位？

- A. 仅涉及三级查房制度
- B. 三级查房和危急值报告及值班交接制度 ✓
- C. 仅涉及手术安全核查制度
- D. 仅涉及病历管理制度
- E. 仅涉及查对制度问题

正确答案：B

💡 术后出现感染征象未及时向上级报告违反了三级查房制度；感染相关的检验异常可能涉及危急值报告；跨班次的病情变化涉及交接班制度。这是多制度执行不到位的复合问题。

⚠ 易错点：可能只见单一制度漏洞而忽略系统性的制度执行缺陷。

---

## 161. YHGT-Ch8-B1-001a

B1型题(匹配) | 记忆 | 正选题 | 难度0.72 | 📖 P150-P155

(共用选项：A.30个工作日 B.5个工作日 C.15个工作日 D.7个工作日 E.60个工作日) 医患冲突人民调解，提出申请后完成调解的时限是？

- A. 30个工作日 ☒
- B. 5个工作日
- C. 15个工作日
- D. 7个工作日
- E. 60个工作日

正确答案：A

💡 人民调解委员会应在受理后30个工作日内完成调解。此为时限，可延长但需双方同意。

⚠ 易错点：容易将人民调解30个工作日与行政调解5个工作日混淆。

---

## 162. YHGT-Ch8-B1-001b

B1型题(匹配) | 记忆 | 正选题 | 难度0.74 | 📖 P150-P155

(共用选项同上) 行政调解中，卫生行政部门做出是否受理决定的时限是？

- A. 30个工作日
- B. 5个工作日 ☒
- C. 15个工作日
- D. 7个工作日
- E. 60个工作日

正确答案：B

💡 卫生行政部门收到行政调解申请后，应在5个工作日内决定是否受理。注意与人民调解30个工作日完成时限的区别。

⚠ 易错点：可能将行政调解受理时限与人民调解完成时限数值混淆。

---

## 163. YHGT-Ch8-B1-002a

B1型题(匹配) | 理解 | 正选题 | 难度0.68 | 📖 P144-P148

(共用选项: A.换位思考 B.依法处置 C.诚实守信 D.公正合理 E.平等尊重) "如果我是患者家属,遇到这种情况我也会很着急"体现的原则是?

- A. 换位思考 ☒
- B. 依法处置
- C. 诚实守信
- D. 公正合理
- E. 平等尊重

**正确答案: A**

💡 设身处地从患方角度理解情绪,是换位思考原则的典型应用。

⚠ 易错点:可能将换位思考与平等尊重混淆。换位思考侧重情感理解,平等尊重侧重态度。

---

## 164. YHGT-Ch8-B1-002b

**B1型题(匹配)** | 理解 | 正选题 | 难度0.66 | 📖 P144-P148

(共用选项同上) "经过调查,护士确实存在发药错误,我们不回避这个失误"体现的原则是?

- A. 换位思考
- B. 依法处置
- C. 诚实守信 ☒
- D. 公正合理
- E. 平等尊重

**正确答案: C**

💡 承认错误、不回避事实,是诚实守信原则的核心体现。

⚠ 易错点:可能将承认错误归为换位思考或公正合理。

---

## 165. YHGT-Ch8-J-001

**判断题** | 理解 | 正选题 | 难度0.68 | 📖 P150-P155

行政调解和人民调解的完成时限完全相同,都是30个工作日。

- A. 正确
- B. 错误 ☒

**正确答案: B**



💡 该陈述错误。行政调解是5个工作日内决定是否受理；人民调解是30个工作日内完成调解。两者时限不同。

⚠️ 易错点：容易将两种调解的时限数值混淆。

---

## 166. YHGT-Ch8-J-003

判断题 | 理解 | 正选题 | 难度0.7 | 📖 P150-P155

人民调解达成协议后，双方当事人可以向人民法院申请司法确认，经确认的调解协议具有强制执行力。

- A. 正确 ☒
- B. 错误

正确答案：A

💡 根据人民调解法，调解协议可申请司法确认，经法院确认后具有强制执行力，增强了调解的法律效力。

⚠️ 易错点：可能不清楚人民调解协议的司法确认程序。

---

## 167. YHGT-Ch8-X-001

X型题(多选) | 记忆 | 正选题 | 难度0.56 | 📖 P144-P148

应对医患冲突的沟通原则包括哪些？（多选）

- A. 平等尊重原则 ☒
- B. 诚实守信原则 ☒
- C. 换位思考原则 ☒
- D. 公正合理原则 ☒
- E. 依法处置原则 ☒

正确答案：ABCDE

💡 应对冲突的六大原则还包括适度体语原则（本题未列全但所列五项均正确）。所有选项均为正确的冲突沟通原则。

⚠️ 易错点：可能不熟悉完整的原则体系。

---

## 168. YHGT-Ch8-X-002

X型题(多选) | 记忆 | 正选题 | 难度0.62 | P148-P150

医患冲突中语言沟通的主要方式包括哪些？（多选）

- A. 协商沟通 ☒
- B. 解释说明 ☒
- C. 命令威胁
- D. 道歉表达 ☒
- E. 调解斡旋 ☒

正确答案：ABDE

💡 冲突语言沟通方式包括协商(A)、解释(B)、道歉(D)、调解(E)。命令威胁(C)是破坏性沟通，会激化冲突。

⚠️ 易错点：可能将冲突中的对抗性言语误认为正式沟通方式。

## 169. YHGT-Ch8-X-003

X型题(多选) | 理解 | 正选题 | 难度0.58 | P144-P148

关于医患冲突中"换位思考"原则，以下理解正确的是？（多选）

- A. 从患者的角度理解其情绪和需求 ☒
- B. 不等于完全认同患方的所有诉求 ☒
- C. 意味着放弃医生的专业判断
- D. 意味着回避所有分歧
- E. 是做好冲突沟通的重要前提 ☒

正确答案：ABE

💡 换位思考是理解患者处境(A)，但不等于放弃专业立场(B)，是冲突沟通的前提(E)。C/D是对换位思考的曲解。

⚠️ 易错点：可能将换位思考误解为无原则妥协或回避分歧。

## 170. YHGT-Ch8-X-004

X型题(多选) | 理解 | 正选题 | 难度0.54 | P150-P155

关于医患纠纷的调解途径，以下描述正确的是？（多选）

- A. 人民调解由人民调解委员会主持 ☒
- B. 行政调解由卫生行政部门主持 ☒
- C. 两种调解都不收取任何费用

- D. 人民调解完成后可申请司法确认 ☒
- E. 行政调解不是诉讼的前置必要程序 ☒

**正确答案：ABDE**

💡 ABDE均正确。C错误在于：人民调解不收费但行政调解的收费规定可能有差异。D正确——调解协议可申请司法确认以增强执行力。E正确——可直接诉讼。

⚠️ 易错点：可能对调解途径的具体规定记忆不清。

## 第九章 公共卫生服务的沟通

### 171. YHGT-Ch9-A1-001

**A1型题** | 记忆 | 正选题 | 难度0.7 | 📖 P157-P160

**健康管理的主要目标人群不包括？**

- A. 健康体检人群
- B. 急性传染病患者 ☒
- C. 慢性病高危人群
- D. 慢性病患者
- E. 具有危险因素的人群

**正确答案：B**

💡 健康管理三大目标人群：健康体检人群、慢性病高危人群、慢性病患者。急性传染病患者属于传染病管理范畴而非健康管理。

⚠️ 易错点：可能将健康管理与疾病治疗混淆。

### 172. YHGT-Ch9-A1-002

**A1型题** | 记忆 | 正选题 | 难度0.72 | 📖 P157-P162

**健康管理的具体内容按流程排序正确的是？**

- A. 干预→评估→信息收集→效果评价
- B. 效果评价→干预→评估→信息收集
- C. 信息收集→风险评估→干预→效果评价 ☒
- D. 风险评估→效果评价→信息收集→干预
- E. 信息收集→效果评价→干预→风险评估

**正确答案：C**

💡 健康管理四步流程：信息收集→风险评估→干预→效果评价，形成闭环管理。

⚠️ 易错点：可能将流程顺序颠倒。

## 173. YHGT-Ch9-A1-003

A1型题 | 记忆 | 正选题 | 难度0.74 | 📖 P170-P172

公共卫生事件的特点不包括？

- A. 突发性
- B. 公共性
- C. 严重性
- D. 可预测性 ☒
- E. 复杂性

正确答案：D

💡 公共卫生事件四大特点：突发性、公共性、严重性、复杂性。可预测性与突发性相矛盾，公共卫生事件的核心特点之一就是难以预测。

⚠️ 易错点：可能将公共卫生事件理想化为可预防可预测的事件。

## 174. YHGT-Ch9-A1-004

A1型题 | 记忆 | 正选题 | 难度0.68 | 📖 P172-P174

根据我国规定，公共卫生事件分为几级？最高级别由哪级政府响应？

- A. 三级，最高由省级政府响应
- B. 五级，最高由国家卫健委响应
- C. 四级，最高由国务院响应 ☒
- D. 三级，最高由市级政府响应
- E. 四级，最高由省级政府响应

正确答案：C

💡 公共卫生事件分四级：I级(特别重大/红色)-国务院、II级(重大/橙色)-省级、III级(较大/黄色)-市级、IV级(一般/蓝色)-县级。

⚠️ 易错点：容易混淆分级数量和各级响应主体。

## 175. YHGT-Ch9-A1-005

### 危机中公众接受信息的特点不包括？

- A. 理性分析能力增强 ☒
- B. 首因效应显著
- C. 倾向于简单化理解复杂信息
- D. 对谣言和虚假信息易感
- E. 对权威信息来源依赖性增强

正确答案：A

💡 危机中公众信息接受特点包括首因效应(B)、简化需求(C)、谣言易感(D)、权威依赖(E)。A与实际情况相反，危机时公众理性分析能力通常下降而非增强。

⚠️ 易错点：可能假设公众在危机中更加理性，但研究发现恰恰相反。

---

## 176. YHGT-Ch9-A1-006

### 医养结合机构内沟通的核心原则不包括？

- A. 尊重老年人和家属
- B. 耐心细致的沟通方式
- C. 家属积极参与
- D. 以机构利益为中心 ☒
- E. 多学科协作沟通

正确答案：D

💡 医养结合沟通原则包括尊重(A)、耐心(B)、家属参与(C)、多学科协作(E)等以老人为中心的沟通策略。D违背以老年人为中心的原则。

⚠️ 易错点：可能将机构管理便利置于服务质量之上。

---

## 177. YHGT-Ch9-A1-007

### 医养结合养老服务的主要难点不包括？

- A. 老年人口数量不足 ☒
- B. 支付体系不健全
- C. 专业人才短缺

- D. 服务标准不统一
- E. 医疗与养老衔接不畅

**正确答案：A**

💡 医养结合难点包括支付体系问题(B)、人才短缺(C)、标准不一(D)、衔接不畅(E)。A与事实相反，我国老年人口基数庞大且持续增长。

⚠️ 易错点：可能不熟悉医养结合领域的具体挑战。

## 178. YHGT-Ch9-A2-001

**A2型题(案例分析)** | 应用 | 正选题 | 难度0.56 | 📖 P157-P160

一位社区医生为45岁男性进行健康管理，该男性BMI 28、空腹血糖6.3mmol/L、有高血压家族史但尚未诊断慢性病。该居民属于健康管理的哪类目标人群？

- A. 健康体检人群
- B. 已确诊慢性病患者
- C. 慢性病高危人群 ☒
- D. 急性病恢复期人群
- E. 不需要健康管理的人群

**正确答案：C**

💡 具有肥胖、血糖偏高、家族史等多个危险因素但尚未确诊疾病者，属于慢性病高危人群——健康管理的重点目标人群。

⚠️ 易错点：可能将其简单归为健康人群而忽略其高危状态。

## 179. YHGT-Ch9-A2-002

**A2型题(案例分析)** | 应用 | 正选题 | 难度0.54 | 📖 P172-P174

某市发生一起学校食物中毒事件，波及3所学校共120名学生，引起社会广泛关注。根据公共卫生事件分级，该事件最可能属于？

- A. I级（特别重大）
- B. II级（重大）
- C. IV级（一般）
- D. III级（较大） ☒
- E. 不属于公共卫生事件

**正确答案：D**

💡 波及一定范围、影响百余人、引起社会关注的食物中毒，符合Ⅲ级（较大）公共卫生事件的特征。需根据具体危害程度和波及范围综合判定。

⚠️ 易错点：可能将学校食物中毒一律归为重大事件。

## 180. YHGT-Ch9-A2-003

A2型题(案例分析) | 应用 | 正选题 | 难度0.52 | 📖 P174-P176

在突发公共卫生事件初期，官方尚未发布详细信息，社交媒体上已出现多种版本的事件描述。从危机沟通角度看，最优先的措施是？

- A. 等技术调查有明确结论后再统一发布
- B. 尽快发布已知的确认信息，承诺持续更新 ☒
- C. 删除社交媒体上的所有讨论
- D. 召开大型新闻发布会详细披露所有细节
- E. 仅向政府部门内部通报

正确答案：B

💡 危机沟通原则：首因效应要求尽快发布确认信息（即使不完整），抢占信息主动权，避免“信息真空”被谣言填补。

⚠️ 易错点：可能认为信息不完整就不应该发布。

## 181. YHGT-Ch9-A2-004

A2型题(案例分析) | 应用 | 正选题 | 难度0.58 | 📖 P167-P169

一位85岁养老机构老人多次向护工反映身体不适，但沟通困难（老人听力差且方言重）。最恰当的沟通对策是？

- A. 因沟通困难暂不处理，等待老人主动明确表达
- B. 直接转到医院住院处理
- C. 由护工自行判断老人需求
- D. 减少与老人的沟通以节省时间
- E. 联系家属了解老人情况，结合非语言观察和耐心沟通 ☒

正确答案：E

💡 医养结合沟通原则：尊重耐心+家属参与+多学科协作。对沟通困难老人应综合家属信息、非语言观察和耐心沟通。

⚠️ 易错点：可能因沟通困难而放弃沟通或草率处理。

---

## 182. YHGT-Ch9-A2-005

A2型题(案例分析) | 理解 | 正选题 | 难度0.54 | 📖 P162-P164

社区医生在健康教育讲座中讲解"盐与高血压的关系"。为了使宣教更有效，最合适的做法是？

- A. 用每天食盐量（克）的直观展示和"隐形盐"食物举例 ☒
- B. 详细讲解肾素-血管紧张素-醛固酮系统的分子机制
- C. 直接告知减少吃盐即可，不需要解释原因
- D. 分发专业的医学论文供居民阅读
- E. 只在高血压患者中进行宣教

正确答案：A

💡 健康知识宣教的核心是通俗化和可操作化。直观展示+生活举例比专业机制讲解对公众更有效。

⚠️ 易错点：可能认为越专业越有效，忽略受众接受能力。

---

## 183. YHGT-Ch9-A2-006

A2型题(案例分析) | 理解 | 正选题 | 难度0.52 | 📖 P164-P166

线上医疗健康管理平台（如互联网医院）沟通的主要优势是？

- A. 可以部分替代线下面对面诊疗
- B. 不存在任何非语言信息缺失
- C. 便捷性——突破时间和空间限制 ☒
- D. 隐私保护比线下更好
- E. 适合所有类型的医疗问题

正确答案：C

💡 线上医疗的核心优势是便捷性（随时随地）。但它不能完全替代线下（A错），非语言信息确实会缺失（B错），隐私保护有额外挑战（D错）。

⚠️ 易错点：可能高估线上医疗的能力或低估其局限性。

---

## 184. YHGT-Ch9-A2-007

A2型题(案例分析) | 理解 | 正选题 | 难度0.56 | 📖 P167-P169



医养结合机构中，一位半失能老人对新来的护工表现出抵触情绪。从沟通原则角度，最先应采取的措施是？

- A. 更换护工人员并重新培训
- B. 耐心与老人建立护患互信关系 ☒
- C. 告知老人必须配合护工工作
- D. 减少对老人的护理服务
- E. 请家属强制老人接受护理

**正确答案：B**

💡 医养结合沟通以尊重和耐心为首要原则。建立信任需要时间，不能因最初的抵触就更换或强制。

⚠️ 易错点：可能因效率考虑直接更换人员或强制老人。

---

## 185. YHGT-Ch9-A2-008

A2型题(案例分析) | 应用 | 正选题 | 难度0.58 | 📖 P157-P162

社区医生在健康管理中对一位高血压高危居民（BMI 29、有家族史、喜咸食）制定干预计划。从健康管理流程角度，"减少每日食盐摄入至5克以下"属于哪个环节？

- A. 健康信息收集
- B. 健康风险评估
- C. 健康管理效果评价
- D. 健康干预 ☒
- E. 健康知识宣教

**正确答案：D**

💡 健康管理四步：信息收集（了解食盐摄入量）→风险评估（判断为高危）→干预（制定减盐目标）→效果评价（复查评估）。制定减盐目标是干预环节。

⚠️ 易错点：可能将干预与宣教混淆。宣教是提供知识，干预是制定行为改变目标。

---

## 186. YHGT-Ch9-A2-009

A2型题(案例分析) | 应用 | 正选题 | 难度0.52 | 📖 P164-P166

互联网医院平台上的医生接诊一位患者，患者描述"最近总是头晕"。线上沟通相对于线下最大的局限在于？

- A. 无法开具电子处方
- B. 无法进行体格检查和非语言信息的缺失 
- C. 无法看到患者的检验报告
- D. 无法与患者进行语言沟通
- E. 线上沟通完全没有优势

**正确答案：B**

 线上医疗最大局限是无法体格检查（听诊/触诊等）和非语言信息（面色/步态/体态等）的缺失。但仍可以进行语言沟通、查看报告和开具电子处方。

 易错点：可能高估或低估线上医疗的能力。

## 187. YHGT-Ch9-A2-010

**A2型题(案例分析)** | 应用 | 正选题 | 难度0.56 |  P174-P176

突发公共卫生事件初期，某市卫健委发布了第一条官方通报。从首因效应角度，该通报最重要的是？

- A. 发布时间最早——在谣言广泛传播前抢占信息先机 
- B. 内容最详细——包含事件的所有科学数据
- C. 措辞最谨慎——不确认的信息一个字都不提
- D. 篇幅最长——涵盖事件的所有方面
- E. 由最高领导亲自发布

**正确答案：A**

 首因效应的核心是"先入为主"——最早发布的信息对公众认知影响最大。危机沟通首要原则是尽快发布已确认的基本信息，占领信息制高点。

 易错点：可能认为内容完整比时间优先更重要。

## 188. YHGT-Ch9-A3-001

**A3型题(病例串)** | 分析 | 正选题 | 难度0.44 |  P170-P176

（案例）某地区出现群体性不明原因发热事件初期，社交媒体谣言四起。卫生部门决定召开新闻发布会。

从公共卫生事件危机沟通角度，发布会内容的最优组合策略是？

- A. 只发布已完全确认的信息，任何不确定的内容都不提
- B. 详细披露所有已掌握和正在调查中的全部信息
- C. 强调事件不严重以安抚公众

- D. 发布已确认事实，说明调查进展，提供后续渠道及防护建议 ☒
- E. 由医院分别发布各自的信息

**正确答案：D**

💡 危机沟通的最佳实践：已知说清+未知坦诚+渠道明确+行动指导。既诚实又提供掌控感。

⚠️ 易错点：可能倾向于只发布确定信息或过度披露。

## 189. YHGT-Ch9-A3-002

**A3型题(病例串)** | 分析 | 正选题 | 难度0.46 | 📖 P170-P176

**（同案例）新闻发布会后部分市民仍然恐慌并抢购物资。从公众接受信息特点和健康行为改变角度，下一步沟通策略应侧重？**

- A. 重复发布会内容不变
- B. 利用基层医生进行一对一沟通，发挥权威信使引导作用 ☒
- C. 不再发布任何信息以免加剧恐慌
- D. 强制市民停止抢购行为
- E. 告知市民恐慌是正常的无需干预

**正确答案：B**

💡 危机中公众对权威信息来源有依赖性，但大众媒体信息可能不够个性化。基层医生作为“可信赖的信使”进行面对面的个性化沟通，是第二步的有效策略。

⚠️ 易错点：可能认为一次发布会就够了。

## 190. YHGT-Ch9-B1-001a

**B1型题(匹配)** | 记忆 | 正选题 | 难度0.74 | 📖 P172-P174

**（共用选项：A.I级/红色 B.II级/橙色 C.III级/黄色 D.IV级/蓝色 E.无需分级）涉及多个省份、需国务院统一组织协调的特别重大公共卫生事件，属于？**

- A. I级（红色） ☒
- B. II级（橙色）
- C. III级（黄色）
- D. IV级（蓝色）
- E. 无需分级

**正确答案：A**

💡 I级（特别重大/红色）：跨省域、需国务院统一指挥，危害特别严重。

⚠️ 易错点：可能将跨省事件仅归为II级。

## 191. YHGT-Ch9-B1-001b

B1型题(匹配) | 记忆 | 正选题 | 难度0.76 | 📖 P172-P174

（共用选项同上）仅影响个别社区、县级政府即可处置的一般公共卫生事件，属于？

- A. I级（红色）
- B. II级（橙色）
- C. III级（黄色）
- D. IV级（蓝色） ☒
- E. 无需分级

正确答案：D

💡 IV级（一般/蓝色）：影响范围限于个别社区，县级政府即可处置。

⚠️ 易错点：可能低估事件仍需分级管理的要求。

## 192. YHGT-Ch9-J-001

判断题 | 理解 | 正选题 | 难度0.72 | 📖 P172-P174

公共卫生事件仅分为三级，最高级别由省级政府负责响应。

- A. 正确
- B. 错误 ☒

正确答案：B

💡 该陈述错误。公共卫生事件分四级，最高级别（I级）由国务院负责响应，省级政府负责II级。

⚠️ 易错点：容易混淆分级数量和各级响应主体。

## 193. YHGT-Ch9-X-001

X型题(多选) | 记忆 | 正选题 | 难度0.62 | 📖 P157-P160

健康管理的主要目标人群包括哪些？（多选）

- A. 健康体检人群 ☒
- B. 急性传染病患者
- C. 慢性病高危人群 ☒
- D. 慢性病患者 ☒
- E. 所有住院患者

**正确答案：ACD**

💡 健康管理三大目标人群：健康体检人群(A)、慢性病高危人群(C)、慢性病患者(D)。B和E不是健康管理的特定目标人群。

⚠️ 易错点：可能将健康管理与疾病治疗人群混淆。

---

## 194. YHGT-Ch9-X-002

**X型题(多选)** | 记忆 | 正选题 | 难度0.64 | 📖 P170-P172

**公共卫生事件的特点包括哪些？（多选）**

- A. 突发性——难以预测 ☒
- B. 公共性——影响广泛 ☒
- C. 可预测性——可通过常规监测完全预防
- D. 严重性——危害公众健康 ☒
- E. 复杂性——涉及多方面因素 ☒

**正确答案：ABDE**

💡 四大特点：突发性(A)、公共性(B)、严重性(D)、复杂性(E)。C与突发性矛盾。

⚠️ 易错点：可能将理想的监测体系效果等同于可完全预测。

---

## 195. YHGT-Ch9-X-003

**X型题(多选)** | 理解 | 正选题 | 难度0.54 | 📖 P167-P170

**关于医养结合养老服务，以下描述正确的是？（多选）**

- A. 目前不存在任何困难和挑战
- B. 支付体系不健全是主要难点之一 ☒
- C. 专业养老服务人才短缺 ☒
- D. 医疗与养老服务衔接不够顺畅 ☒
- E. 服务标准和质量参差不齐 ☒

**正确答案：BCDE**

💡 医养结合面临支付体系(B)、人才(C)、衔接(D)、标准(E)等多方面挑战。A否认问题的存在，不符合实际。

⚠️ 易错点：可能认为政策已完全解决医养结合问题。

## 196. YHGT-Ch9-X-004

X型题(多选) | 理解 | 正选题 | 难度0.52 | 📖 P174-P176

危机中公众接受信息的特点包括哪些？（多选）

- A. 首因效应——最早获得的信息影响最大 ✓
- B. 深度分析能力增强——能理性评估复杂信息
- C. 简化需求——倾向于简单化的解释 ✓
- D. 谣言易感性——在信息不确定性时更容易相信谣言 ✓
- E. 权威依赖——对官方和专家信息的依赖性增强 ✓

正确答案：ACDE

💡 危机中公众信息处理特点：首因效应(A)、简化需求(C)、谣言易感(D)、权威依赖(E)。B与事实相反——危机时深度分析能力反而下降。

⚠️ 易错点：可能假设公众在危机中更加理性。

## 第十章 医学研究中的沟通

### 197. YHGT-Ch10-A1-001

A1型题 | 记忆 | 正选题 | 难度0.72 | 📖 P181-P183

医学研究中的参与者（受试者）不包括？

- A. 自愿参加临床试验的患者
- B. 健康志愿者
- C. 提供生物样本的捐献者
- D. 伦理委员会的审查委员 ✓
- E. 完成问卷调查的受访者

正确答案：D

💡 研究参与者包括受试者、健康志愿者、样本捐献者等。伦理委员会是独立的审查监督机构，不属于研究参与者。

⚠️ 易错点：可能将伦理委员会成员误认为研究参与者。

---

## 198. YHGT-Ch10-A1-002

A1型题 | 理解 | 正选题 | 难度0.6 | 📖 P183-P185

研究参与者的依从性对临床试验最重要的影响是？

- A. 仅影响研究的伦理审批
- B. 直接影响数据质量、安全性评价和结论可靠性 ☒
- C. 仅影响研究经费的使用效率
- D. 仅影响研究者发表论文的速度
- E. 与研究结果无关

正确答案：B

💡 依从性是临床试验的基石——参与者不依从会导致数据质量下降、安全性评估偏差、样本量不足进而影响结论可靠性。

⚠️ 易错点：可能低估依从性对研究结果的决定性影响。

---

## 199. YHGT-Ch10-A1-003

A1型题 | 记忆 | 正选题 | 难度0.66 | 📖 P185-P188

实施知情同意沟通中常见的问题不包括？

- A. 研究参与者对信息理解不足
- B. 自愿性受损——受不当影响或胁迫
- C. 研究参与者过度了解研究全部细节 ☒
- D. 信息过载导致决策困难
- E. 文化和语言障碍影响理解

正确答案：C

💡 知情同意常见问题包括理解不足(A)、自愿性受损(B)、信息过载(D)、文化障碍(E)。C与常见问题相反——通常参与者是理解不足而非了解过多。

⚠️ 易错点：可能认为越详细越好而忽略信息过载问题。

---

## 200. YHGT-Ch10-A1-004

A1型题 | 记忆 | 正选题 | 难度0.7 | 📖 P188-P190

常用的知情同意方式不包括？

- A. 社交媒体公示 ☒
- B. 书面知情同意书
- C. 口头知情同意
- D. 电子知情同意
- E. 见证人签署的知情同意

**正确答案：A**

💡 常用知情同意方式包括书面(B)、口头(C)、电子(D)、见证人签署(E)。社交媒体公示(A)不是标准知情同意方式，不满足个体化和隐私保护要求。

⚠️ 易错点：可能将公开告知与个体知情同意混淆。

## 201. YHGT-Ch10-A2-001

**A2型题(案例分析)** | 应用 | 正选题 | 难度0.54 | 📖 P185-P188

在获得偏远地区农村老人的临床试验知情同意时，研究者发现老人不识字、说方言。最合适的知情同意方式是？

- A. 仅提供书面知情同意书让其按手印
- B. 使用方言口头解释，见证人在场，采用口头知情同意+见证人签署 ☒
- C. 因沟通困难排除该老人参与研究
- D. 让其子女代为签署而无需告知老人研究内容
- E. 简化知情同意过程，只告知大概内容

**正确答案：B**

💡 面对低文化水平和文化差异，应采用口头知情同意+见证人签署。必须确保信息以可理解的方式传达，不能绕过本人。

⚠️ 易错点：可能因沟通困难直接排除或简化过程。

## 202. YHGT-Ch10-A2-002

**A2型题(案例分析)** | 应用 | 正选题 | 难度0.56 | 📖 P190-P192

研究者向受试者解释随机对照试验时说："您会被随机分到A组或B组，就像抛硬币一样，由计算机决定。"这运用了哪种提高沟通效果的技巧？

- A. 分阶段告知
- B. 确认理解
- C. 书面材料辅助



- D. 通俗化语言和生动比喻 ☒
- E. 多学科团队沟通

**正确答案：D**

💡 使用"抛硬币"比喻解释随机化概念，将专业术语转化为通俗易懂的日常语言，是提高研究沟通效果的核心技巧之一。

⚠️ 易错点：可能认为使用专业术语更显正规。

## 203. YHGT-Ch10-A2-003

**A2型题(案例分析)** | 应用 | 正选题 | 难度0.52 | 📖 P183-P185

一项降压药临床试验中，部分受试者因感觉"血压已经正常"而自行停药。这最直接影响了研究的哪个方面？

- A. 伦理委员会审批
- B. 研究经费预算
- C. 受试者依从性及研究数据质量 ☒
- D. 研究者发表优先权
- E. 药品生产许可

**正确答案：C**

💡 自行停药直接反映依从性问题，将导致数据缺失、偏倚、统计效能降低，最终影响研究结论的可靠性。

⚠️ 易错点：可能低估依从性对数据质量的决定性影响。

## 204. YHGT-Ch10-A2-004

**A2型题(案例分析)** | 理解 | 正选题 | 难度0.56 | 📖 P185-P188

在知情同意过程中，研究者提供了长达15页的专业知情同意书。从知情同意沟通角度，这可能导致什么问题？

- A. 完全满足知情同意的法律要求
- B. 信息过载——参与者无法有效理解关键信息 ☒
- C. 研究参与者的依从性必然提高
- D. 参与者对研究更加信任
- E. 知情同意过程更高效

**正确答案：B**

💡 过长的专业知情同意书是信息过载的典型表现——参与者难以从大量专业文字中提取和记住关键信息，反而削弱了知情同意的实质效果。

⚠️ 易错点：可能认为知情同意书越详细越好。

## 205. YHGT-Ch10-A2-005

A2型题(案例分析) | 理解 | 正选题 | 难度0.58 | 📖 P190-P192

研究者发现受试者对“随机分组”这一概念普遍理解困难。提高沟通效果的最佳技巧是？

- A. 跳过这一概念，直接让受试者签署同意书
- B. 用专业术语反复解释直到对方理解
- C. 告知受试者“这不是您需要关心的内容”
- D. 使用通俗比喻（如抽签/抛硬币）并请受试者用自己的话复述 ☒
- E. 只向受试者家属解释

正确答案：D

💡 通俗化语言+图示辅助+确认理解（teach-back）是提高研究沟通效果的三大技巧。抛硬币比喻+复述确认正好运用了其中两个。

⚠️ 易错点：可能认为专业术语更准确而坚持使用，忽略受试者的理解困难。

## 206. YHGT-Ch10-A2-006

A2型题(案例分析) | 理解 | 正选题 | 难度0.58 | 📖 P188-P190

研究对象为文盲时，最恰当的知情同意方式是？

- A. 仅让研究者在知情同意书上代为签字
- B. 将该研究对象排除出试验
- C. 口头告知即可无需书面记录
- D. 口头详细解释+见证人在场+见证人签署知情同意书 ☒
- E. 由家属直接代签无需告知本人

正确答案：D

💡 对文盲受试者应采用口头知情同意+公正见证人签署的方式，确保受试者本人理解并自愿参与。不能因为文盲就绕过知情同意或由他人替代。

⚠️ 易错点：可能因沟通困难而简化或省略知情同意。

## 207. YHGT-Ch10-A2-007

A2型题(案例分析) | 理解 | 正选题 | 难度0.56 | 📖 P185-P188

研究者向受试者充分告知了研究风险和获益，受试者表示理解并同意参加。但研究者发现受试者签署同意书时手在发抖。这提示知情同意可能存在什么问题？

- A. 形式上的同意——受试者口头同意但内心仍有恐惧或犹豫 ☒
- B. 知情同意过程完美无缺
- C. 受试者完全理解并自愿参加
- D. 发抖与知情同意无关可以忽略
- E. 应该停止研究取消所有知情同意

**正确答案：A**

💡 签署同意书时发抖提示可能存在“形式同意”——受试者签字了但内心有恐惧或犹豫。这要求研究者进一步确认自愿性和理解度。

⚠️ 易错点：可能认为签字就是同意，忽略非语言线索。

## 208. YHGT-Ch10-A2-008

A2型题(案例分析) | 应用 | 正选题 | 难度0.56 | 📖 P190-P192

研究者在解释一项双盲随机对照试验时，受试者反复询问“我吃的到底是真药还是安慰剂”。研究者最恰当的回答是？

- A. 告诉受试者“我不能告诉你”
- B. 暗示受试者吃的是真药以增强依从性
- C. 解释双盲设计为科学评价疗效所需，说明安全监测机制会全程保障 ☒
- D. 告知受试者如果想知道可以去检验科查
- E. 告诉受试者吃的一定是真药

**正确答案：C**

💡 对双盲设计的困惑是知情同意中的常见问题。应诚实解释设计的科学意义，同时告知安全保障措施（如有安全问题会揭盲）。不能撒谎也不能冷漠拒绝。

⚠️ 易错点：可能简单告知“不能告诉你”或暗示吃的是真药。

## 209. YHGT-Ch10-A3-001

A3型题(病例串) | 应用 | 正选题 | 难度0.54 | 📖 P181-P192

（案例串题）一项新药临床试验招募受试者。研究者准备了12页的知情同意书。第一位受试者是一位68岁、仅小学文化的农村老人。

Q1：从知情同意沟通角度，研究者应如何调整沟通策略？

- A. 使用标准知情同意书，按统一流程宣读
- B. 因老人文化程度低，直接排除不纳入研究
- C. 使用通俗口语解释核心内容，放慢语速，分阶段告知，请老人复述确认理解 
- D. 让老人家属代为理解并签署即可
- E. 缩短知情同意书，只告知好处不强调风险

正确答案：C

💡 面对低文化受试者，应调整沟通策略而非降低伦理标准：通俗化语言+分阶段+确认理解。不能因文化程度低就排除或绕过本人。

⚠️ 易错点：可能认为低文化受试者不适合参加研究或需简化伦理流程。

## 210. YHGT-Ch10-A3-002

A3型题(病例串) | 应用 | 正选题 | 难度0.52 | 📖 P181-P192

（同案例）老人听完解释后点头表示同意，但其儿子私下告诉研究者“我爸其实没太听懂，但他不好意思说”。研究者此时最应该？

- A. 既然老人签字了，按照流程继续进行
- B. 暂停入组，重新解释关键内容并核实理解，辅以图示 
- C. 直接将该受试者排除出研究
- D. 让儿子签字替代老人的知情同意
- E. 告知伦理委员会该老人不适合参加研究

正确答案：B

💡 知情同意的核心是“理解”而非“签字”。发现可能存在理解不足时，应暂停入组、改变沟通方式再次确认理解。这是研究伦理的基本要求。

⚠️ 易错点：可能认为签字即有效，忽略理解维度的评估。

## 211. YHGT-Ch10-J-001

判断题 | 理解 | 正选题 | 难度0.74 | 📖 P181-P183

伦理委员会成员不属于医学研究中的“研究参与者”范畴，而是独立的审查监督机构成员。

- A. 正确 ☒
- B. 错误

**正确答案：A**

💡 研究参与者指受试者、健康志愿者、样本捐献者等。伦理委员会是独立的审查机构，其成员不参与研究本身。

⚠️ 易错点：可能将伦理审查角色与受试者角色混淆。

---

## 212. YHGT-Ch10-J-002

判断题 | 理解 | 正选题 | 难度0.7 | 📖 P183-P185

受试者依从性不佳会直接影响临床试验的数据质量、安全性评价和结论可靠性。

- A. 正确 ☒
- B. 错误

**正确答案：A**

💡 依从性是临床试验的基石。不依从导致数据缺失、偏倚和结论不可靠。

⚠️ 易错点：可能低估依从性对研究结果的深远影响。

---

## 213. YHGT-Ch10-J-003

判断题 | 理解 | 正选题 | 难度0.68 | 📖 P185-P188

只要受试者在知情同意书上签字，就说明知情同意过程完全有效，不需要额外确认理解。

- A. 正确
- B. 错误 ☒

**正确答案：B**

💡 该陈述错误。签字不等于理解。有效的知情同意需要确认受试者真正理解信息，而非仅获得签名。形式同意是知情同意的常见问题之一。

⚠️ 易错点：可能将"签字"等同于"知情同意全过程有效"。

---

## 214. YHGT-Ch10-X-001

X型题(多选) | 记忆 | 正选题 | 难度0.58 | 📖 P185-P188

## 实施知情同意沟通中常见的问题包括哪些？（多选）

- A. 研究参与者对信息理解不足 ☒
- B. 自愿性受损——受不当影响 ☒
- C. 信息过载导致决策困难 ☒
- D. 文化和语言障碍影响理解 ☒
- E. 研究参与者过度了解全部细节

**正确答案：ABCD**

💡 常见问题包括理解不足(A)、自愿性受损(B)、信息过载(C)、文化障碍(D)。E与事实相反。

⚠️ 易错点：可能认为越详细越好。

---

## 215. YHGT-Ch10-X-002

**X型题(多选)** | 记忆 | 正选题 | 难度0.64 | 📖 P188-P190

### 常用的知情同意方式包括哪些？（多选）

- A. 书面知情同意书 ☒
- B. 口头知情同意 ☒
- C. 电子知情同意 ☒
- D. 见证人签署的知情同意 ☒
- E. 社交媒体公示

**正确答案：ABCD**

💡 标准知情同意方式包括书面(A)、口头(B)、电子(C)、见证人签署(D)。E不满足个体化和隐私要求。

⚠️ 易错点：可能将公开告知与个体知情同意混淆。

---

## 216. YHGT-Ch10-X-003

**X型题(多选)** | 理解 | 正选题 | 难度0.56 | 📖 P190-P192

### 提高医学研究沟通效果的技巧包括哪些？（多选）

- A. 使用通俗化语言替代专业术语 ☒
- B. 图示辅助——用图片帮助理解 ☒
- C. 分阶段告知——避免一次性信息过载 ☒

- D. 使用复杂的专业表述以保证信息准确
- E. 确认理解——请受试者用自己的话复述 

**正确答案：ABCE**

💡 提高沟通效果的技巧包括通俗化(A)、图示(B)、分阶段(C)、确认理解(E)。D与通俗化原则相反。

⚠️ 易错点：可能认为专业术语更“准确”而忽略理解度。

## 217. YHGT-Ch10-X-004

**X型题(多选)** | 理解 | 正选题 | 难度0.54 | 📖 P181-P185

**医学研究中的多方参与者包括哪些？（多选）**

- A. 受试者/健康志愿者 
- B. 研究者/申办方 
- C. 伦理委员会 
- D. 监管机构 
- E. 数据安全监察委员会 

**正确答案：ABCDE**

💡 医学研究涉及多利益相关方：受试者(A)、研究者/申办方(B)、伦理委员会(C)、监管机构(D)、数据监察(E)等。

⚠️ 易错点：可能遗漏部分利益相关方。

## 附：十八项核心制度

### 218. YHGT-A3-001

**A3型题(病例串)** | 应用 | 正选题 | 难度0.5 | 📖 P85-P100

（案例题共用题干）一位68岁男性因胸痛2小时到急诊就诊。心电图示急性前壁心肌梗死。家属情绪激动。

**问题1：急诊医生此时最优先的沟通策略是？**

- A. 详细解释心肌梗死的全部病理机制
- B. 简要告知病情和紧急处理计划，承诺稍后详细沟通 
- C. 让家属先交费再谈治疗方案
- D. 等所有检查结果出来后再告知
- E. 仅与患者本人沟通，不理睬家属

正确答案：B

💡 急诊沟通核心：在紧急处置同时向家属做出时间承诺——告知当前情况和计划，承诺稍后详谈。

⚠️ 易错点：可能认为急诊只需抢救不需沟通。

## 219. YHGT-A3-002

A3型题(病例串) | 应用 | 正选题 | 难度0.48 | 📖 P85-P100

（同案例题干）医生在急诊PCI术后告知家属手术成功，但患者需在CCU观察。此时家属开始抱怨“为什么这么晚才发现”。根据冲突沟通原则，医生最恰当的做法是？

- A. 反驳：“我们已经是第一时间抢救了”
- B. 不理睬抱怨，直接交代术后注意事项
- C. 先共情回应情绪，再客观解释疾病突发性和抢救及时性 ✓
- D. 请保安将家属带离
- E. 告诉家属可以向医务科投诉

正确答案：C

💡 冲突沟通原则：先换位思考+共情回应情绪（理解家属着急），再客观解释事实。不要对抗或回避。

⚠️ 易错点：可能采取防御姿态或用制度回应。

## 220. YHGT-A3-003

A3型题(病例串) | 分析 | 正选题 | 难度0.42 | 📖 P85-P100

（同案例题干）患者术后第3天，家属发现护士发药时未严格执行查对制度，情绪激动地要求见科主任。从多制度协同角度，该事件涉及哪些核心制度？（多因素分析）

- A. 仅涉及查对制度要求
- B. 涉及查对制度和三级查房制度
- C. 涉及查对制度和危急值报告制度
- D. 涉及三级查房制度和值班交接班制度
- E. 涉及查对制度、三级查房制度和冲突沟通原则 ✓

正确答案：E

💡 该场景是多制度交汇的复杂案例：查对制度执行不到位是根因；三级查房制度中科主任职责被触发；冲突沟通原则指导如何与家属沟通。



⚠ 易错点：可能只见树木不见森林，只关注单一制度。

## 221. YHGT-A3-004

A3型题(病例串) | 应用 | 正选题 | 难度0.52 | 📖 P157-P190

（案例题共用题干）某社区卫生服务中心开展糖尿病高危人群筛查和健康管理项目。筛查对象需签署知情同意书。

问题1：该项目知情同意应包含的基本要素不包括？

- A. 研究目的和流程说明
- B. 可能的获益和风险评估
- C. 保证参与者一定能从项目中获益 ✓
- D. 自愿参加和随时退出的权利
- E. 隐私保护和数据使用说明

正确答案：C

💡 知情同意不能承诺一定获益（研究不同于临床诊疗）。C违背诚实告知原则，知情同意必须客观说明可能获益而非保证获益。

⚠ 易错点：可能将临床诊疗的获益承诺与研究项目的知情同意混淆。

## 222. YHGT-A3-005

A3型题(病例串) | 应用 | 正选题 | 难度0.54 | 📖 P157-P190

（同案例题干）在项目实施中，健康管理师发现一位居民空腹血糖8.0mmol/L但从未就医。健康管理师应该？

- A. 直接给予降糖药物处方
- B. 告知其为糖尿病高危/疑似患者，建议尽快就医确诊 ✓
- C. 忽略该发现继续原计划
- D. 告知其已确诊糖尿病并开始治疗
- E. 只记录数据不做任何告知

正确答案：B

💡 健康管理师职责：发现异常应告知和引导就医，但不能替代医生进行诊断和处方。这属于健康管理干预中的沟通责任。

⚠ 易错点：可能混淆健康管理师与医生职责边界。

## 223. YHGT-A3-006

A3型题(病例串) | 分析 | 正选题 | 难度0.44 | 📖 P157-P190

(同案例题干) 项目进行中当地出现食品安全事件引发公众恐慌，部分参与者要求退出项目。从公共卫生事件沟通和医学研究伦理角度，项目组最恰当的综合应对策略是？

- A. 拒绝任何人退出，以保证研究样本量
- B. 暂停全部研究活动直到事件平息
- C. 仅告知参与者退出将影响研究结果
- D. 尊重退出权利+提供公共卫生事件权威信息+安抚情绪+做好退出记录 ☒
- E. 尊重退出者决定并完成退出记录

正确答案：D

💡 需综合两维度：研究伦理维度——保障退出权利（知情同意核心）；公共卫生维度——危机沟通（首因效应+权威信息）；关系维度——换位思考+共情。

⚠️ 易错点：可能偏重其中一个维度而忽略综合应对。

## 224. YHGT-A4-001

A4型题(病例串) | 应用 | 正选题 | 难度0.48 | 📖 P144-P155

(串题) 患者王先生，52岁，因胆囊结石行腹腔镜胆囊切除术。术后第2天出现腹痛、发热，B超提示腹腔积液。家属认为“手术没做好”，情绪激动。

Q1: 根据冲突沟通原则，经治医生首先应？

- A. 倾听家属诉求，表达理解和共情 ☒
- B. 立即承认手术失误并道歉
- C. 告知家属这是常见并发症，无需担心
- D. 让科室主任来处理
- E. 建议家属直接走医疗鉴定程序

正确答案：A

💡 冲突沟通第一步是运用换位思考和共情，先倾听和理解，而非急于下结论或推卸。承认错误需在事实调查清楚后进行。

⚠️ 易错点：可能急于承认或否认而跳过倾听和共情环节。

## 225. YHGT-A4-002

A4型题(病例串) | 应用 | 正选题 | 难度0.5 | 📖 P144-P155

(同串题) 经检查确认腹腔积液为胆汁漏, 需再次手术。医生告知家属时, 应用SPIKES模型中的哪个步骤最为关键?

- A. Setting——准备私密安静的谈话环境
- B. Perception——先了解家属已知多少
- C. Invitation——询问家属想知道多少
- D. Knowledge+Empathy——清晰告知同时共情回应情绪 
- E. Strategy——直接讨论再次手术的方案

**正确答案: D**

 告知"坏消息"(并发症需再次手术)时, Knowledge(告知)和Empathy(共情)的结合最为关键。既要说清楚事实, 又要回应情绪。

 易错点: 可能过于侧重信息告知而忽略情绪共情。

---

## 226. YHGT-A4-003

**A4型题(病例串)** | 分析 | 正选题 | 难度0.42 |  P144-P155

(同串题) 二次手术后患者康复良好, 但家属坚持要求"给个说法"并拒绝出院。从多维度分析, 此时最应优先启动的机制是?

- A. 直接上报法院等候判决
- B. 请保安强制患者出院
- C. 启动院内多部门调解机制并适时引入第三方调解 
- D. 满足家属所有要求以避免冲突升级
- E. 将该患者列入"困难患者"名单限制后续就诊

**正确答案: C**

 沟通协商不成时应启动正式调解机制(院内→人民调解→行政调解逐步升级)。这是依法处置原则和分级调解路径的体现。

 易错点: 可能跳过调解环节直接走极端(诉讼或全盘满足要求)。

---

## 227. YHGT-B1-003a

**B1型题(匹配)** | 记忆 | 正选题 | 难度0.76 |  P172-P174

(共用选项: A.I级/红色/国务院 B.II级/橙色/省级 C.III级/黄色/市级 D.IV级/蓝色/县级 E.不分级) 跨省域流行的新发传染病, 需国务院统一领导处置, 属于?

- A. I级（红色）——国务院 ☒
- B. II级（橙色）——省级
- C. III级（黄色）——市级
- D. IV级（蓝色）——县级
- E. 无对应分级响应措施

**正确答案：A**

💡 跨省域+国务院统一领导，符合I级（特别重大）特征。

⚠️ 易错点：可能将跨省事件仅归为II级。

---

## 228. YHGT-B1-003b

**B1型题(匹配)** | 记忆 | 正选题 | 难度0.74 | 📖 P172-P174

（共用选项同上）仅限一个地级市范围内的食物中毒事件，市级政府负责响应，属于？

- A. I级（红色）——国务院
- B. II级（橙色）——省级
- C. III级（黄色）——市级 ☒
- D. IV级（蓝色）——县级
- E. 无对应分级响应措施

**正确答案：C**

💡 限于一个地级市范围、市级政府负责，符合III级（较大）特征。

⚠️ 易错点：可能将市级事件归为县级响应或省级响应。

---

## 229. YHGT-ZD-A1-001

**A1型题** | 记忆 | 正选题 | 难度0.68 | 📖 P-

**首诊负责制度的核心要求是？**

- A. 首诊医师仅负责挂号分诊
- B. 患者可以自由选择任一医师首诊
- C. 首诊医师对患者的诊疗全程负责 ☒
- D. 首诊仅限于急诊患者
- E. 首诊医师可将患者直接转给任何科室

**正确答案：C**

💡 首诊负责制度要求首诊医师对患者从接诊到明确诊断或转诊的全过程负责，不得推诿患者。

⚠️ 易错点：可能将首诊负责理解为仅做初步分诊。

---

## 230. YHGT-ZD-A1-002

A1型题 | 记忆 | 正选题 | 难度0.72 | 📖 P-

三级查房制度中，三级医师从低到高依次是？

- A. 主任医师→主治医师→住院医师
- B. 住院医师→主治医师→（副）主任医师 ☒
- C. 实习医师→住院医师→主治医师
- D. 住院医师→副主任医师→院长
- E. 主治医师→副主任医师→主任医师

正确答案：B

💡 三级查房制度要求：住院医师每日查房、主治医师每周至少2次、副主任医师/主任医师每周至少1次查房。

⚠️ 易错点：可能对三级医师的层级顺序记忆有误。

---

## 231. YHGT-ZD-A1-003

A1型题 | 记忆 | 正选题 | 难度0.66 | 📖 P-

关于死亡病例讨论制度，以下哪项是正确的？

- A. 死亡病例无需讨论
- B. 死亡后24小时内必须完成讨论
- C. 仅由主治医师单独完成
- D. 死亡后1周内完成讨论 ☒
- E. 仅涉及医疗纠纷的死亡病例才需要讨论

正确答案：D

💡 死亡病例讨论制度要求死亡后1周内完成讨论，由科主任主持，全体医护人员参加。

⚠️ 易错点：可能将时限与其它制度混淆。

---

## 232. YHGT-ZD-A1-004

A1型题 | 记忆 | 正选题 | 难度0.7 |  P-

危急值报告制度要求检验科发现危急值后应？

- A. 立即报告临床科室 ☒
- B. 等全部检验结果出来一起报告
- C. 仅在白班时间报告
- D. 先记录在案，次日晨会报告
- E. 直接录入电子病历即可

正确答案：A

 危急值指危及患者生命的检验结果，必须立即报告临床科室，不得延误。

 易错点：可能低估危急值的紧急性。

---

### 233. YHGT-ZD-A1-005

A1型题 | 记忆 | 正选题 | 难度0.64 |  P-

手术安全核查制度要求在几个时间点进行三方核查？

- A. 一个时间点：术前
- B. 两个时间点：术前和术后
- C. 三个时间点：麻醉前、切皮前、离室前 ☒
- D. 四个时间点：术前中术后及出院前
- E. 不需特定时间点

正确答案：C

 手术安全核查在三个时间点进行：麻醉开始前、手术切皮前、患者离开手术室前，由麻醉医生、手术医生和手术室护士三方共同核查。

 易错点：可能遗漏某个核查时间点。

---

### 234. YHGT-ZD-A1-006

A1型题 | 记忆 | 正选题 | 难度0.68 |  P-

抗菌药物分级管理制度将抗菌药物分为哪三级？

- A. 一线、二线、三线
- B. 非限制使用级、限制使用级、特殊使用级 ☒
- C. 口服级、注射级、外用级

- D. 基本级、中级、高级
- E. 普通级、加强级、保留级

**正确答案：B**

💡 抗菌药物分三级管理：非限制使用级（初级职称医师可用）、限制使用级（中级及以上）、特殊使用级（高级职称或科主任）。

⚠️ 易错点：可能使用非标准术语描述三级分类。

---

## 235. YHGT-ZD-J-001

| 判断题 | 理解 | 正选题 | 难度0.72 | 📖 P-

**死亡病例讨论必须在患者死亡后24小时内完成。**

- A. 正确
- B. 错误 ☒

**正确答案：B**

💡 该陈述错误。死亡病例讨论应在死亡后1周内完成，非24小时内。

⚠️ 易错点：容易将时限与其他制度混淆。

---

## 236. YHGT-ZD-J-002

| 判断题 | 理解 | 正选题 | 难度0.74 | 📖 P-

**手术安全核查应在麻醉开始前、手术切皮前、患者离开手术室前三个时间点进行。**

- A. 正确 ☒
- B. 错误

**正确答案：A**

💡 手术安全核查的三方三次核查（麻醉前/切皮前/离室前）是核心制度的明确要求。

⚠️ 易错点：可能遗漏某个时间点。

---

## 237. YHGT-ZD-X-001

| X型题(多选) | 记忆 | 正选题 | 难度0.56 | 📖 P-

以下哪些属于十八项医疗质量安全核心制度？（多选）

- A. 首诊负责制度 ☒
- B. 三级查房制度 ☒
- C. 会诊制度 ☒
- D. 危急值报告制度 ☒
- E. 手术安全核查制度 ☒

正确答案：ABCDE

💡 所有选项均属于十八项核心制度。十八项核心制度涵盖了诊疗全过程的质量安全关键环节。

⚠️ 易错点：可能不熟悉完整核心制度清单。

## 238. YHGT-ZD-X-002

X型题(多选) | 记忆 | 正选题 | 难度0.6 | 📖 P-

以下哪些属于手术相关的核心制度？（多选）

- A. 手术分级管理制度 ☒
- B. 术前讨论制度 ☒
- C. 手术安全核查制度 ☒
- D. 急危重症患者抢救制度 ☒
- E. 病历管理制度

正确答案：ABCD

💡 手术相关制度包括手术分级(A)、术前讨论(B)、安全核查(C)。危急重症抢救制度(D)也与急诊手术相关。E属于文书管理非手术专项。

⚠️ 易错点：可能遗漏与手术间接相关的制度。

## 239. YHGT-ZD-X-003

X型题(多选) | 记忆 | 正选题 | 难度0.58 | 📖 P-

以下哪些制度直接涉及患者信息与知情同意？（多选）

- A. 病历管理制度 ☒
- B. 临床用血审核制度 ☒
- C. 信息安全管理制度的 ☒



- D. 抗菌药物分级管理制度
- E. 新技术新项目准入制度 ☒

正确答案：ABCE

💡 病历管理(A)、用血审核(B/含知情同意)、信息安全(C)、新技术准入(E/含伦理审批)均涉及患者信息或知情同意。D涉及药物管理而非直接信息/知情同意。

⚠️ 易错点：可能忽略用血审核和新技术的知情同意要素。

---

## 240. YHGT-ZD-X-004

X型题(多选) | 理解 | 正选题 | 难度0.54 | 📖 P-

关于查对制度，以下描述正确的是？（多选）

- A. 操作前核对患者身份信息 ☒
- B. 操作中核对药品和剂量 ☒
- C. 操作后再次核对并记录 ☒
- D. 仅在手术室中执行
- E. 适用于所有诊疗操作环节 ☒

正确答案：ABCE

💡 查对制度要求操作前(A)、中(B)、后(C)三阶段核对，适用于所有诊疗操作(E)，不限于手术室(D)。

⚠️ 易错点：可能认为查对制度仅针对手术或给药。

---